妇产科学教学题库

妇产科学教学计划版题库（batch034） 题库（250题）

> 来源：最终产物\batch034\ALL_questions_FIXED.json ｜ 导出：2026-09-07 10:14
> 题型分布：A1×100、A2×74、B1×24、X×27、A3×12、A4×13
> Bloom分布：理解×93、记忆×79、应用×66、分析×12

M1（19题）

1. [A1型题｜记忆] batch034-M1-A1-001

> 模块：M1｜页码：教材P10

非孕时子宫峡部的长度约为

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm ✅
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

答案：B

> 解析：子宫峡部位于子宫体与宫颈之间最狭窄的部位，非孕时长约1cm，妊娠末期可达7～10cm形成子宫下段，为剖宫产常用切口。教材P10。

---

2. [A1型题｜记忆] batch034-M1-A1-002

> 模块：M1｜页码：教材P12

输卵管由内向外分为的四部分依次为

- A. 间质部、峡部、壶腹部、伞部 ✅

- B. 峡部、间质部、壶腹部、伞部
- C. 伞部、壶腹部、峡部、间质部
- D. 间质部、壶腹部、峡部、伞部
- E. 峡部、壶腹部、间质部、伞部

答案：A

> 解析：输卵管全长8～14cm，由内向外分为间质部（潜行于宫壁）、峡部（细直、结扎部位）、壶腹部（宽大、受精部位）、伞部（拾卵）。教材P12。

---

3. [A1型题｜记忆] batch034-M1-A1-003

> 模块：M1｜页码：教材P14

子宫动脉在宫颈内口水平横跨输尿管的位置位于输尿管的

- A. 上方 ✅
- B. 下方
- C. 内侧
- D. 外侧
- E. 后方

答案：A

> 解析：子宫动脉为髂内动脉前干分支，在宫颈内口水平、宫颈外侧约1.5～2cm处横跨输尿管上方至子宫侧缘，妇科手术中游离此动脉时需注意避免损伤其下方输尿管。教材P14。

---

4. [A1型题｜记忆] batch034-M1-A1-004

> 模块：M1｜页码：教材P16

坐骨结节间径的正常参考值为

- A. 6.5～7.5cm
- B. 7.5～8.5cm
- C. 8.5～9.5cm ✅
- D. 9.5～10.5cm

- E. 10.5～11.5cm

答案：C

> 解析：坐骨结节间径（出口横径）正常值为8.5～9.5cm，是骨盆出口平面重要径线，与出口后矢状径之和＞15cm提示出口狭窄不明显。教材P16。

---

5. [A1型题｜记忆] batch034-M1-A1-005

> 模块：M1｜页码：教材P30

以28日为一周期，子宫内膜分泌期出现含糖原核下空泡的时期是

- A. 增殖早期
- B. 增殖晚期
- C. 分泌早期 ✅
- D. 分泌中期
- E. 分泌晚期

答案：C

> 解析：分泌早期（第15～19日）特征为出现含糖原的核下空泡，分泌中期（第20～23日）呈顶浆分泌达高峰，分泌晚期（第24～28日）呈海绵状。教材P30。［源:考研真题 GS-2022-016］

---

6. [A1型题｜理解] batch034-M1-A1-006

> 模块：M1｜页码：教材P27

在月经周期中，出现两次分泌高峰的激素是

- A. 促卵泡激素（垂体前叶分泌）
- B. 黄体生成素（垂体前叶分泌）
- C. 雌激素（卵泡及黄体分泌） ✅
- D. 孕激素（黄体分泌）
- E. 促性腺激素释放激素（下丘脑分泌）

答案：C

> 解析：雌激素在月经周期中出现两次分泌高峰：第一次在排卵前1天（卵泡成熟高峰），第二次在排卵后7～8日（黄体期高峰）。孕激素、FSH、LH、GnRH均只有一次高峰。教材P27。[源:考研真题 GS-2014-024]

---

7. [A1型题｜理解] batch034-M1-A1-007

> 模块：M1｜页码：教材P29

关于子宫内膜周期性变化的顺序，不正确的是

- A. 月经期→增殖期→分泌期
- B. 增殖期腺体增多弯曲、间质水肿
- C. 分泌期子宫内膜厚度可达12mm
- D. 基底层不随性激素波动而脱落 ✅
- E. 分泌晚期间质蜕膜样变

答案：D

> 解析：子宫内膜功能层受性激素调节发生周期性脱落（月经期），基底层不受性激素影响、不脱落，是月经后内膜再生的来源。增殖期腺体增多弯曲，分泌晚期呈海绵状蜕膜样变。教材P10、P29。 [源:考研真题 GS-2022-016]

---

8. [A1型题｜理解] batch034-M1-A1-008

> 模块：M1｜页码：教材P25

排卵前诱发LH峰形成所必需的关键因素是

- A. 孕激素分泌出现高峰
- B. 雌激素≥200pg/ml持续48h ✅
- C. FSH分泌水平急剧升高
- D. 抑制素分泌水平下降
- E. GnRH脉冲分泌频率减慢

答案：B

> 解析：排卵前成熟卵泡分泌大量雌激素，当血中雌激素浓度≥200pg/ml并持续48h时，对下丘脑和垂体产生正反馈作用，诱发LH/FSH排卵峰，其中LH峰是触发排卵的关键。教材P25。[源:考研真题 GS-2009-022]

---

9. [A2型题｜理解] batch034-M1-A2-001

> 模块：M1｜页码：教材P32

女，28岁，月经规律。月经第27日，血中雌激素和孕激素水平均显著下降，导致子宫内膜脱落的直接原因是

- A. 雌孕激素撤退引起螺旋动脉痉挛性收缩 ✅
- B. LH峰诱发前列腺素释放
- C. FSH促进内膜增殖
- D. GnRH抑制内膜血供
- E. hCG维持黄体分泌孕激素功能

答案：A

> 解析：黄体退化后雌孕激素撤退，引起子宫内膜螺旋动脉痉挛性收缩，导致内膜缺血坏死脱落形成月经。月经血含纤维蛋白溶解酶故不凝。教材P32。［源:考研真题 GS-2011-022］

---

10. [A2型题｜理解] batch034-M1-A2-002

> 模块：M1｜页码：教材P25

在卵泡期，多个卵泡同时发育，最终只有一个优势卵泡发育成熟并排卵。其主要原因是

- A. 优势卵泡分泌更多雌激素，摄取更多FSH ✅
- B. 优势卵泡分泌更多孕激素
- C. 优势卵泡分泌更多抑制素促进FSH分泌
- D. 优势卵泡对LH的敏感性更高
- E. 优势卵泡体积最大，不受FSH调控

答案：A

> 解析：优势卵泡分泌雌激素能力强，卵泡液中高浓度雌激素可协同FSH促进颗粒细胞增生，提高卵泡对FSH的敏感性；同时雌激素负反馈抑制FSH分泌，使其他对FSH不敏感的卵泡闭锁。教材P25。［源:考研真题 GS-2016-024］

---

11. [A2型题｜应用] batch034-M1-A2-003

> 模块：M1｜页码：教材P27

女，30岁，因月经失调就诊。关于雌孕激素生理作用的比较，下列错误的是

- A. 雌激素促进子宫肌增生肥大
- B. 孕激素使基础体温升高0.3～0.5℃
- C. 雌激素使宫颈黏液稀薄拉丝度增加
- D. 孕激素促进乳腺腺管发育 ✅
- E. 雌激素促进水钠潴留

答案：D

> 解析：雌激素促进乳腺腺管发育，孕激素促进乳腺腺泡发育。孕激素使基础体温升高、宫颈黏液变稠减少、抑制子宫收缩。雌激素促子宫肌增生、宫颈黏液稀薄拉丝、水钠潴留。教材P27-28。［源:考研真题 GS-2013-023］

---

12. [A2型题｜应用] batch034-M1-A2-004

> 模块：M1｜页码：教材P18

女，65岁，G3P3，自觉阴道口有块状物脱出半年。妇科检查见宫颈及部分宫体脱出阴道口外。与该病发生关系最不密切的结构是

- A. 肛提肌
- B. 主韧带
- C. 宫骶韧带
- D. 卵巢固有韧带 ✅
- E. 会阴深横肌

答案：D

> 解析：子宫脱垂的主要解剖支持结构为盆膈（肛提肌为主）、主韧带（固定宫颈）、宫骶韧带（维持前屈）及会阴深横肌等。卵巢固有韧带连接卵巢与子宫角，与子宫脱垂无关。教材P18。

---

13. [A2型题｜应用] batch034-M1-A2-005

> 模块：M1｜页码：教材P24

女，25岁。B超监测卵泡发育，月经第12日见左侧卵巢有一优势卵泡直径18mm，内膜厚约10mm。该卵泡最可能于何时排卵

- A. 当日排卵
- B. 次日～两日内 ✅
- C. 3～4日后
- D. 5～6日后
- E. 7日后

答案：B

> 解析：卵泡直径达18～23mm即为成熟卵泡，排卵多在下次月经前14日左右。在28日周期中，月经第12日接近排卵期，成熟卵泡一般于1～2日内排出。排卵前E2正反馈诱发LH峰是排卵的关键触发器。教材P24-25。

---

14. [A2型题｜理解] batch034-M1-A2-006

> 模块：M1｜页码：教材P29

女，32岁。月经周期第15日行诊断性刮宫，病理报告为'分泌早期子宫内膜'。该患者最可能处于卵巢周期的

- A. 卵泡早期
- B. 卵泡晚期
- C. 排卵期
- D. 黄体早期 ✅
- E. 黄体晚期

答案：D

> 解析：分泌早期子宫内膜（第15～19日，核下空泡为特征）对应卵巢黄体早期（排卵后1～4日）。排卵后卵泡壁塌陷形成黄体，分泌孕激素使内膜由增殖期转化为分泌期。教材P29-30。

---

15. [A4型题｜应用] batch034-M1-A4-001

> 模块：M1｜页码：教材P14

女，45岁。因多发性子宫肌瘤行全子宫切除术。术中处理子宫动脉时，关于输尿管损伤风险的判断，正确的是

- A. 子宫动脉在输尿管下方横过，需先游离输尿管
- B. 子宫动脉横过输尿管上方，钳夹时避开输尿管 ✅
- C. 输尿管距子宫动脉约3cm，一般不会损伤
- D. 输尿管在子宫动脉外侧走行，不形成交叉
- E. 子宫动脉和输尿管无固定解剖关系

答案：B

> 解析：子宫动脉在宫颈内口水平、宫颈外侧约1.5～2cm处横跨输尿管上方至子宫侧缘，输尿管位于子宫动脉下方。手术中应先将子宫动脉游离抬起，避开其下方输尿管再钳夹切断，以防误伤输尿管致输尿管瘘。教材P14。

---

16. [B1型题｜记忆] batch034-M1-B1-001

> 模块：M1｜页码：教材P28

促进乳腺腺管发育的主要激素是

- A. 雌激素（卵巢分泌） ✅
- B. 孕激素（黄体分泌）
- C. 雄激素（肾上腺及卵巢分泌）
- D. 催乳素（垂体前叶分泌）
- E. 人绒毛膜促性腺激素（胎盘分泌）

答案：A

> 解析：雌激素促进乳腺腺管（导管）发育，孕激素促进乳腺腺泡发育；二者协同使乳房充分发育为产后泌乳做准备。教材P28。［源:考研真题 GS-2015-024］

---

17. [B1型题｜记忆] batch034-M1-B1-002

> 模块：M1｜页码：教材P27

使子宫内膜由增殖期转化为分泌期的激素是

- A. 雌激素（卵巢分泌）
- B. 孕激素（黄体分泌） ✅
- C. 雄激素（肾上腺及卵巢分泌）
- D. 催乳素（垂体前叶分泌）
- E. 人绒毛膜促性腺激素（胎盘分泌）

答案：B

> 解析：排卵后黄体分泌孕激素，促使增殖期子宫内膜转化为分泌期子宫内膜，为受精卵着床做准备。若未受精，黄体退化、雌孕激素撤退，内膜脱落形成月经。教材P27-28。［源:考研真题 GS-2015-024］

---

18. [X型题｜理解] batch034-M1-X1-001

> 模块：M1｜页码：教材P27

雌激素和孕激素共同的生理作用包括

- A. 促进子宫内膜增厚 ✅
- B. 促进乳腺发育 ✅
- C. 使宫颈黏液分泌减少
- D. 抑制输卵管平滑肌收缩
- E. 促进水钠潴留

答案：AB

> 解析：雌激素和孕激素共同促进子宫内膜增厚（雌激素促增殖、孕激素促分泌）和乳腺发育（雌激素促腺管、孕激素促腺泡）。使宫颈黏液减少、抑制输卵管收缩、促进水钠潴留均为雌激素或孕激素的单项作用。教材P27-28。

---

19. [X型题｜理解] batch034-M1-X2-001

> 模块：M1｜页码：教材P30

月经周期第15～19日（分泌早期）子宫内膜的病理特征包括

- A. 出现含糖原核下空泡 ✅
- B. 腺体呈锯齿状
- C. 顶浆分泌达高峰
- D. 螺旋小动脉发育 ✅
- E. 间质水肿明显

答案：AD

> 解析：分泌早期（第15～19日）特征为出现含糖原核下空泡（腺上皮分泌活动开始）。螺旋小动脉在此期发育。腺体锯齿状和顶浆分泌达高峰为分泌中期特征；间质水肿明显为增殖中期特征。教材P30。

M2（20题）

20. [A1型题｜记忆] batch034-M2-A1-001

> 模块：M2｜页码：教材P36

卵子受精的常见部位是

- A. 输卵管间质部
- B. 输卵管峡部
- C. 输卵管壶腹部 ✅
- D. 输卵管伞部
- E. 子宫腔

答案：C

> 解析：受精发生在输卵管壶腹部，多数在排卵后数小时内（不超过24小时）。精子需获能约7小时并发生顶体反应才能与次级卵母细胞融合。教材P36。

---

21. [A1型题｜记忆] batch034-M2-A1-002

> 模块：M2｜页码：教材P37

受精卵开始着床的时间是受精后

- A. 1～2日
- B. 3～4日
- C. 6～7日 ✅
- D. 10～12日
- E. 14～15日

答案：C

> 解析：受精卵着床始于受精后6～7日，此时囊胚透明带消失、合体滋养细胞分化。着床窗口期在月经周期第20～24日，由黄体分泌的雌孕激素支撑。教材P37。

---

22. [A1型题｜记忆] batch034-M2-A1-003

> 模块：M2｜页码：教材P37

从末次月经第1日起算，妊娠10周内的人胚称为

- A. 囊胚
- B. 桑葚胚
- C. 胚胎 ✅
- D. 胎儿
- E. 胚泡

答案：C

> 解析：妊娠10周（受精第8周）内的人胚称胚胎（器官分化形成期），妊娠11周（受精第9周）起称胎儿（各器官继续生长成熟）。孕周从末次月经第1日起算，全程约280日40周。教材P37。

---

23. [A1型题｜理解] batch034-M2-A1-004

> 模块：M2｜页码：教材P38

关于胎儿循环，下列叙述正确的是

- A. 胎儿体内有纯动脉血
- B. 脐静脉内为含氧量低的血
- C. 脐动脉内为含氧量高的血
- D. 下腔静脉血绝大部分经卵圆孔入左心房 ✅
- E. 动脉导管连接脐静脉与下腔静脉

答案：D

> 解析：胎儿体内无纯动脉血，为动静脉混合血。脐静脉内为含氧量高的血（来自胎盘），脐动脉内为含氧量低的血（流回胎盘）。下腔静脉血绝大部分经卵圆孔入左心房。动脉导管连接肺动脉与主动脉弓。教材P38。

---

24. [A1型题｜记忆] batch034-M2-A1-005

> 模块：M2｜页码：教材P43

足月妊娠（40周）时羊水量约为

- A. 300ml
- B. 500ml
- C. 800ml ✅
- D. 1000ml
- E. 1200ml

答案：C

> 解析：羊水量妊娠38周约1000ml达峰值，此后逐渐减少，40周约800ml，过期妊娠可减至300ml以下。羊水来源：早期为母血清透析液，中期后以胎儿尿液为主，晚期胎肺也参与生成。教材P43。

---

25. [A1型题｜记忆] batch034-M2-A1-006

> 模块：M2｜页码：教材P41

人绒毛膜促性腺激素（hCG）在孕妇血清中达高峰的孕周是

- A. 妊娠4～6周
- B. 妊娠8～10周 ✅
- C. 妊娠12～14周
- D. 妊娠16～20周
- E. 妊娠晚期

答案：B

> 解析：hCG由合体滋养细胞分泌，受精卵着床后1日即可从母体血清测出，妊娠8～10周达高峰，以后迅速下降，产后2周内消失。hCG可维持妊娠黄体功能。教材P41。［源:考研真题GS-2012-023］

---

26. [A1型题｜理解] batch034-M2-A1-007

> 模块：M2｜页码：教材P41

人胎盘催乳素（hPL）的主要功能是

- A. 维持妊娠黄体功能
- B. 促进腺泡发育并调节母胎代谢 ✅
- C. 刺激胎儿睾丸分泌睾酮
- D. 抑制母体排卵发生
- E. 促进子宫平滑肌收缩

答案：B

> 解析：hPL为单链多肽激素，由合体滋养细胞分泌，妊娠5周可测出、晚期达高峰、产后7小时消失。功能：促进乳腺腺泡发育，促进胰岛素生成，脂解作用提供游离脂肪酸为能源，抑制母体对葡萄糖的利用将糖优先供给胎儿，是'代谢调节因子'。教材P41-42。

---

27. [A1型题｜记忆] batch034-M2-A1-008

> 模块：M2｜页码：教材P45

妊娠期母体血容量达高峰的时期是

- A. 妊娠20～24周
- B. 妊娠24～28周
- C. 妊娠32～34周 ✅
- D. 妊娠36～38周
- E. 妊娠40周

答案：C

> 解析：妊娠期血容量自妊娠6～8周开始增加，32～34周达高峰，增加40%～45%（平均约1450ml），维持至分娩。血浆增加1000ml、红细胞增加450ml，血浆增量多于红细胞导致生理性血液稀释。教材P45。

---

28. [A2型题｜理解] batch034-M2-A2-001

> 模块：M2｜页码：教材P42

女，28岁，妊娠12周。关于妊娠期雌激素和孕激素的来源，正确的是

- A. 由卵巢妊娠黄体分泌激素
- B. 妊娠早期由卵巢黄体产生，10周后胎盘分泌 ✅
- C. 由胎盘合体滋养细胞分泌
- D. 由肾上腺皮质网状带分泌
- E. 由胎儿睾丸间质细胞分泌

答案：B

> 解析：妊娠早期雌激素和孕激素由卵巢黄体（妊娠黄体）产生，维持妊娠。hCG刺激黄体转变为妊娠黄体。妊娠8～10周后胎盘合体滋养细胞逐渐成为主要来源，即'早卵巢、晚胎盘'。教材P42。［源:考研真题 GS-2010-024］

---

29. [A2型题｜理解] batch034-M2-A2-002

> 模块：M2｜页码：教材P42

女，30岁，妊娠32周。关于胎儿-胎盘单位合成的雌激素，含量最高的是

- A. 雌酮
- B. 雌二醇
- C. 雌三醇 ✅
- D. 雌四醇
- E. 己烯雌酚

答案：C

> 解析：妊娠期胎盘合成的雌激素中雌三醇约占90%，雌二醇及雌酮各约占5%。雌三醇的生成需要胎儿肾上腺（产生DHEAS）和胎儿肝脏（16α-羟化酶）参与，因此雌三醇是胎儿-胎盘单位功能的标志物。教材P42。［源:考研真题 GS-2021-016］

---

30. [A2型题｜理解] batch034-M2-A2-003

> 模块：M2｜页码：教材P36

精子的获能通常发生在

- A. 附睾内
- B. 输精管内
- C. 精囊腺内
- D. 女性生殖道内 ✅
- E. 腹腔内

答案：D

> 解析：精子必须在女性生殖道（子宫或输卵管）中停留数小时，获能后才能获得使卵子受精的能力。获能过程使精子顶体表面糖蛋白被降解、顶体膜稳定性降低，准备发生顶体反应。教材P36。［源:考研真题 GS-2006-013］

---

31. [A2型题｜应用] batch034-M2-A2-004

> 模块：M2｜页码：教材P38

关于胎儿血红蛋白的特点，下列叙述错误的是

- A. 胎儿血红蛋白对氧的亲和力高于成人血红蛋白
- B. 妊娠前半期胎儿体内均为胎儿血红蛋白
- C. 临产时胎儿血红蛋白约占25%
- D. 胎儿血红蛋白由α链和β链组成 ✅
- E. 胎儿血红蛋白有利于胎儿从母血中摄取氧

答案：D

> 解析：胎儿血红蛋白（HbF）由α2γ2组成（而非α2β2），其对氧的亲和力高于成人血红蛋白（HbA，α2β2），有利于胎儿从母血中摄取氧。妊娠前半期均为HbF，末4～6周HbA开始增多，临产时HbF约占25%。教材P38。

---

32. [A2型题｜应用] batch034-M2-A2-005

> 模块：M2｜页码：教材P45

女，32岁，妊娠28周，因下肢肿胀就诊。关于妊娠期血液系统变化，正确的是

- A. 凝血因子XI、XIII增加
- B. 纤维蛋白原较非孕增加约50% ✅
- C. PT和APTT显著延长
- D. 血小板计数显著增加
- E. 血液处于低凝状态

答案：B

> 解析：妊娠期血液处于高凝状态，凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ增加，仅Ⅺ及ⅩⅢ减少；PT及APTT轻度缩短；纤维蛋白原较非孕约增加50%（妊娠晚期平均4.5g/L），血管栓塞性疾病风险增加5～6倍。教材P45-46。

---

33. [A2型题｜应用] batch034-M2-A2-006

> 模块：M2｜页码：教材P45

女性，25岁。宫内孕38周，1周来感心悸，平卧位明显气促，双下肢水肿来院。既往有心肌炎史。查体：P120次/分，R18次/分，BP140/90mmHg，高枕卧位，双肺叩清，呼吸音正常，心尖搏动点位于第4肋间左锁骨中线外1.0cm，心律整，可闻及第三心音。该孕妇的体检诊断，不正确的是

- A. 心动过速
- B. 高血压
- C. 心脏扩大 ✅
- D. 正常第三心音
- E. 奔马律

答案：C

> 解析：[源:考研真题 GS-2022-068] 正常妊娠晚期心脏向左、上、前方移位，可闻及第三心音，不应误诊为病理性心脏扩大；心率>100次/分可诊断窦性心动过速；BP140/90mmHg可诊断高血压1级。

---

34. [A3型题｜分析] batch034-M2-A3-001

> 模块：M2｜页码：教材P46

女，29岁，妊娠26周，常规产检尿常规示尿糖（+），空腹血糖4.8mmol/L，75g OGTT：空腹5.1mmol/L，1h 8.9mmol/L，2h 7.2mmol/L。该患者尿糖阳性最可能的原因是

- A. 妊娠期糖尿病
- B. 妊娠期生理性糖尿 ✅
- C. 肾小球肾炎
- D. Fanconi综合征
- E. 糖尿病合并妊娠

答案：B

> 解析：妊娠期肾小球滤过率（GFR）约增加50%，肾小管对葡萄糖的重吸收未相应增加，约15%孕妇饭后出现生理性糖尿。本例OGTT三值均未达GDM诊断标准（空腹≥5.1，1h≥10.0，2h≥8.5mmol/L），故排除妊娠期糖尿病，诊断为生理性糖尿。教材P46。

---

35. [A4型题｜应用] batch034-M2-A4-001

> 模块：M2｜页码：教材P46

女，27岁，妊娠30周。突发右侧腰痛伴寒战高热，体温39.2℃，尿频尿急。查体右肾区叩击痛（+）。尿常规：WBC满视野/HP，可见白细胞管型。血常规：WBC 16×10^9/L，N 0.85。该患者最可能的诊断是，且与妊娠期哪一生理变化相关

- A. 急性膀胱炎；GFR增加
- B. 急性肾盂肾炎；右旋子宫压迫输尿管 ✅
- C. 肾结石；血钙升高
- D. 肾结核；细胞免疫功能下降
- E. 急性肾小球肾炎；血容量增加

答案：B

> 解析：妊娠期增大子宫右旋压迫右侧输尿管，加之孕激素使输尿管平滑肌松弛、蠕动减弱，导致肾盂及输尿管扩张、尿流缓慢，孕妇易患急性肾盂肾炎，右侧居多。本例有高热、腰痛、白细胞管型，符合急性肾盂肾炎。教材P46。

---

36. [B1型题｜记忆] batch034-M2-B1-001

> 模块：M2｜页码：教材P38

胎儿出生后动脉导管闭锁成为

- A. 脐静脉闭锁形成肝圆韧带
- B. 静脉导管闭锁形成静脉韧带
- C. 导管闭锁后形成动脉韧带 ✅
- D. 脐动脉闭锁形成脐内侧韧带
- E. 脐尿管闭锁形成脐正中韧带

答案：C

> 解析：胎儿期动脉导管连接肺动脉与主动脉弓，出生后2～3个月完全闭锁成为动脉韧带。脐静脉闭锁为肝圆韧带，静脉导管闭锁为静脉韧带，脐动脉闭锁为脐内侧韧带。教材P38。

---

37. [B1型题｜记忆] batch034-M2-B1-002

> 模块：M2｜页码：教材P38

胎儿出生后卵圆孔完全关闭的时间是

- A. 出生后立即关闭
- B. 出生后1周内
- C. 出生后1个月内
- D. 出生后约6个月 ✅
- E. 出生后1～2年

答案：D

> 解析：出生后左心房压力增高，卵圆孔开始关闭，多在生后6个月完全关闭。动脉导管生后2～3个月完全闭锁。脐带血管出生后即功能性关闭。教材P38。

---

38. [X型题｜理解] batch034-M2-X1-001

> 模块：M2｜页码：教材P37

受精卵成功着床需要具备的条件包括

- A. 透明带在受精后立即消失
- B. 囊胚透明带消失 ✅
- C. 合体滋养细胞分化 ✅
- D. 囊胚与子宫内膜发育同步 ✅
- E. 母体内有足量的雌孕激素 ✅

答案：BCDE

> 解析：着床需具备四个条件：透明带消失、囊胚细胞滋养细胞分化出合体滋养细胞、囊胚和子宫内膜同步发育并相互配合、母体内有足量孕激素和雌激素。透明带应在着床前（受精后5～6日）消失而非受精后立即消失。教材P37。

---

39. [X型题｜理解] batch034-M2-X2-001

> 模块：M2｜页码：教材P45

妊娠期循环系统的生理性变化包括

- A. 心输出量自妊娠8～10周增加 ✅
- B. 心输出量32～34周达高峰 ✅
- C. 妊娠晚期仰卧位可致血压下降 ✅
- D. 舒张压明显升高
- E. 心脏向左上前方移位 ✅

答案：ABCE

> 解析：妊娠期心输出量自8～10周开始增加，32～34周达高峰（左侧卧位较未孕约增加30%）。妊娠晚期仰卧位时子宫压迫下腔静脉致回心血量减少，可发生仰卧位低血压综合征。心脏向左、上、前方移位。妊娠期舒张压受外周血管扩张而轻度降低而非升高。教材P45。

M3（20题）

40. [A1型题｜记忆] batch034-M3-A1-001

> 模块：M3｜页码：教材P50

早期妊娠确诊最可靠的依据是

- A. 停经10日以上
- B. 出现明显早孕反应
- C. 尿hCG阳性
- D. 超声见宫内孕囊及心管搏动 ✅
- E. 乳房胀痛及蒙氏结节

答案：D

> 解析：血或尿hCG阳性提示妊娠，但确定正常宫内妊娠需超声发现宫内孕囊、胚芽及心管搏动。hCG阳性不能排除异位妊娠或妊娠滋养细胞疾病。停经、早孕反应及乳房变化均为非特异性表现。教材P50。

---

41. [A1型题｜记忆] batch034-M3-A1-002

> 模块：M3｜页码：教材P49

黑加征（Hegar sign）出现于妊娠

- A. 4～5周
- B. 6～8周 ✅
- C. 10～12周
- D. 14～16周
- E. 18～20周

答案：B

> 解析：黑加征为妊娠6～8周双合诊时自觉宫颈与宫体之间似不相连、感觉断离，由子宫峡部极度柔软所致。是早孕典型的软性体征。教材P49。

---

42. [A1型题｜记忆] batch034-M3-A1-003

> 模块：M3｜页码：教材P51

正常胎心率的范围是

- A. 90～120次/分
- B. 100～140次/分
- C. 110～160次/分 ✅
- D. 120～180次/分
- E. 130～170次/分

答案：C

> 解析：正常胎心率110～160次/分。胎心音呈双音、似钟表滴答声，妊娠12周多普勒可探测，18～20周一般听诊器可闻。胎心监护中基线变异是最重要的评价指标。教材P51。

---

43. [A1型题｜记忆] batch034-M3-A1-004

> 模块：M3｜页码：教材P51

最常见的胎产式是

- A. 纵产式 ✅
- B. 横产式
- C. 斜产式
- D. 臀先露
- E. 肩先露

答案：A

> 解析：纵产式（胎体纵轴与母体纵轴平行）占99.75%，其中头先露最常见；横产式仅占0.25%；斜产式为暂时性，多数转为纵产式。教材P51。

---

44. [A1型题｜应用] batch034-M3-A1-005

> 模块：M3｜页码：教材P55

末次月经第1日为2026年3月5日，预产期应为

- A. 2026年12月5日
- B. 2026年12月12日 ✅
- C. 2026年12月19日
- D. 2027年1月12日
- E. 2027年1月19日

答案：B

> 解析：预产期按末次月经第1日起算，月份加9或减3，日数加7。3月+9=12月，5日+7=12日，故预产期为2026年12月12日。若LMP推算与早期超声相差＞5日，应以早期超声校正。教材P55。

45. [A1型题｜记忆] batch034-M3-A1-006

> 模块：M3｜页码：教材P54

我国《孕前和孕期保健指南（2018）》推荐无高危因素的孕妇产前检查次数为

- A. 3～5次
- B. 5～7次
- C. 7～11次 ✅
- D. 11～15次
- E. 15次以上

答案：C

> 解析：我国推荐产前检查7～11次，有高危因素者可酌情增加。37周后每周1次。WHO（2016）对无合并症孕妇建议至少8次。教材P54。

---

46. [A1型题｜理解] batch034-M3-A1-007

> 模块：M3｜页码：教材P59

电子胎心监护中，无应激试验（NST）正常（有反应型）的判断标准是

- A. 基线变异消失
- B. 40分钟内≥2次胎心加速 ✅
- C. 反复晚期减速
- D. 变异减速持续＞60秒
- E. 胎心率基线＜110次/分

答案：B

> 解析：正常NST（有反应型）标准：胎心率基线110～160次/分，中度变异，无减速或偶发变异减速，40分钟内至少有2次胎心加速（≥32周加速≥15次/分、持续≥15秒）。基线变异消失或反复晚期减速为异常。教材P59-60。

---

47. [A1型题｜记忆] batch034-M3-A1-008

> 模块：M3｜页码：教材P66

受精后最容易发生胎儿结构畸形的时期是

- A. 受精后2周内
- B. 受精后3～8周 ✅
- C. 受精后9～12周
- D. 受精后13～20周
- E. 受精后21周至足月

答案：B

> 解析：受精后3～8周为器官高度分化期，是致畸高度敏感期（神经组织15～25日、心脏21～40日、肢体和眼睛24～46日），此期用药易致形态畸形。受精后2周内为'全或无'期，9周后为生长成熟期。教材P66。

---

48. [A2型题｜应用] batch034-M3-A2-001

> 模块：M3｜页码：教材P49

女，28岁，停经52日。近1周出现恶心、晨起呕吐，自觉乳房胀痛。查体：宫颈及阴道黏膜呈紫蓝色，子宫峡部极软，双合诊宫颈与宫体似不相连。该患者最可能的诊断是

- A. 早期妊娠 ✅
- B. 异位妊娠
- C. 葡萄胎
- D. 月经失调
- E. 盆腔炎

答案：A

> 解析：停经52日，早孕反应、乳房胀痛，查体见宫颈紫蓝色（Chadwick征）、黑加征阳性（子宫峡部极软，宫颈与宫体似不相连），符合早期妊娠的临床表现。确诊需行hCG检测及超声检查。教材P49。

---

49. [A2型题｜应用] batch034-M3-A2-002

> 模块：M3｜页码：教材P57

女，30岁，妊娠36周。四步触诊：宫底部触及软而不规则胎臀，腹壁一侧触及平坦饱满的胎背，胎心听诊在脐左下方最清晰。该胎儿的胎方位最可能是

- A. 枕左前 ✅
- B. 枕右前
- C. 骶左前
- D. 骶右前
- E. 肩左前

答案：A

> 解析：宫底部触及胎臀提示头先露（胎头在下方），胎背平坦饱满在腹壁一侧，胎心在脐左下方最清晰，符合枕左前（LOA）的触诊和听诊特点。LOA是最常见的枕前位。教材P57。

---

50. [A2型题｜应用] batch034-M3-A2-003

> 模块：M3｜页码：教材P50

女，26岁，妊娠12周，超声检查。关于早孕期超声检查，下列叙述错误的是

- A. 停经35日宫腔内可见孕囊
- B. 妊娠6周可见胚芽和原始心管搏动
- C. 妊娠14周前测量顶臀长估计孕周最准确
- D. 妊娠11～13⁺⁶周可测NT厚度
- E. CRL估计孕周可用于整个妊娠期 ✅

答案：E

> 解析：CRL（顶臀长）用于14周前估计孕周最准确，14周后应改用双顶径、头围、股骨长等综合判断。停经35日可见孕囊，6周可见胚芽和心管搏动，11～13⁺⁶周可测NT进行染色体筛查。教材P50。

---

51. [A2型题｜应用] batch034-M3-A2-004

> 模块：M3｜页码：教材P59

女，32岁，妊娠32周，因自觉胎动减少来院。自述2小时胎动计数为4次。正确的处理是

- A. 继续观察，无需特殊处理
- B. 立即行剖宫产终止妊娠
- C. 进一步行胎心监护评估胎儿 ✅
- D. 口服地塞米松促胎肺成熟
- E. 行人工破膜引产

答案：C

> 解析：妊娠28周后胎动＜6次/2小时提示胎儿缺氧可能，应进一步行NST、BPP等评估胎儿宫内状况。胎动减少是胎儿缺氧的最早预警信号，需及时评估，但并非立即终止妊娠的指征。教材P59。

---

52. [A2型题｜应用] batch034-M3-A2-005

> 模块：M3｜页码：教材P57

女，28岁，妊娠39周，初产。产科检查：髂棘间径24cm，髂嵴间径27cm，骶耻外径19cm，坐骨结节间径7.0cm，出口后矢状径7.5cm。该骨盆属于

- A. 正常骨盆
- B. 均小骨盆
- C. 扁平骨盆
- D. 漏斗骨盆 ✅
- E. 畸形骨盆

答案：D

> 解析：坐骨结节间径（出口横径）正常8.5～9.5cm，本例7.0cm明显缩短。坐骨结节间径+出口后矢状径=14.5cm＜15cm，提示出口狭窄，符合漏斗骨盆（中骨盆及出口平面狭窄）。骶耻外径正常（18～20cm），入口无狭窄。教材P57-58。

---

53. [A2型题｜理解] batch034-M3-A2-006

> 模块：M3｜页码：教材P59

女，42岁，妊娠15周，G1P0，预产期年龄≥40岁。关于产前筛查与诊断，正确的建议是

- A. 仅行血清学筛查即可
- B. 可直接行介入性产前诊断 ✅
- C. 先行NIPT筛查，阳性再行产前诊断
- D. 无需行特殊产前检查
- E. 妊娠28周后再行超声检查

答案：B

> 解析：预产期年龄≥40岁的孕妇建议直接行介入性产前诊断（如羊膜腔穿刺）排查胎儿非整倍体。预产期年龄35～39岁且单纯年龄为高危因素者，可先行无创产前筛查（NIPT）。教材P59。

---

54. [A3型题｜分析] batch034-M3-A3-001

> 模块：M3｜页码：教材P60

女，29岁，妊娠38周，G1P0，规律宫缩2小时入院。胎心监护示：胎心率基线150次/分，中度变异，宫缩时胎心减速，减速曲线从开始到最低点时间≥30秒，最低点与宫缩峰值同时出现，宫缩结束后减速迅速恢复。该减速类型最可能是

- A. 早期减速，提示胎头受压，属良性 ✅
- B. 晚期减速，提示胎盘灌注不足，需紧急处理
- C. 变异减速，提示脐带受压
- D. 延长减速，提示胎儿窘迫
- E. 正弦波，提示胎儿贫血

答案：A

> 解析：早期减速特点：减速与宫缩同步（最低点与宫缩峰值同时出现），下降幅度一般＜50次/分，宫缩后迅速恢复，多由胎头受压致迷走神经兴奋引起，属良性表现，无需特殊处理。晚期减速最低点落后于宫缩峰值，提示胎盘灌注不足。教材P60。

---

55. [A4型题｜应用] batch034-M3-A4-001

> 模块：M3｜页码：教材P66

女，33岁，妊娠7周。因'上呼吸道感染'就诊，体温38.5℃，自述在受精后第18～20日曾服用过某药物（现已停用），非常担心胎儿畸形风险。关于该患者用药风险的分析，正确的是

- A. 受精后2周内用药为'全或无'，影响不大
- B. 受精后3～8周为致畸敏感期，需评估用药 ✅
- C. 妊娠9周后用药已无致畸风险
- D. 单次用药不会导致胎儿畸形
- E. 孕期用药均属于FDA-X类，均应终止妊娠

答案：B

> 解析：受精后3～8周为器官定向分化期，对致畸因子最敏感，此期用药最易导致形态畸形。受精后2周内为'全或无'（胚早期死亡或继续发育不畸形）。9周后为生长成熟期，主要影响生长和功能。应评估具体药物的FDA分类及暴露时间。教材P66。

---

56. [B1型题｜应用] batch034-M3-B1-001

> 模块：M3｜页码：教材P51

枕先露时，胎心音听诊最清晰的部位是

- A. 脐左下方 ✅
- B. 脐左上方
- C. 脐右上方
- D. 脐部周围
- E. 剑突下

答案：A

> 解析：枕先露（头位）时胎心音在脐左（右）下方最清晰，臀先露在脐左（右）上方，肩先露在靠近脐部下方。听诊部位随胎位而变，因胎心音在靠近胎背上方的孕妇腹壁处最清晰。教材P51。

---

57. [B1型题｜应用] batch034-M3-B1-002

> 模块：M3｜页码：教材P51

臀先露时，胎心音听诊最清晰的部位是

- A. 脐左下方
- B. 脐左上方 ✅
- C. 脐右下方
- D. 脐部周围
- E. 耻骨联合上方

答案：B

> 解析：臀先露时胎心音在脐左（右）上方最清晰，因胎背位于子宫上部，胎心音在靠近胎背处传导最清晰。需与子宫杂音（与母体脉搏一致）、腹主动脉音及脐带杂音鉴别。教材P51。

---

58. [X型题｜记忆] batch034-M3-X1-001

> 模块：M3｜页码：教材P65

妊娠期用药的基本原则包括

- A. 有明确指征，避免不必要的用药 ✅
- B. 选用对胎儿相对安全的药物 ✅
- C. 尽量联合用药以增强疗效
- D. 严格掌握剂量和用药时间，及时停药 ✅
- E. 妊娠早期若病情允许尽量推迟到中晚期用药 ✅

答案：ABDE

> 解析：妊娠期用药原则：有明确指征、选用对胎儿相对安全的药物、尽量单独用药（非联合用药）、选用结论肯定的药物、严格掌握剂量与用药时间并及时停药、妊娠早期若病情允许尽量推迟到中晚期。教材P65。

---

59. [X型题｜理解] batch034-M3-X2-001

> 模块：M3｜页码：教材P60

下列关于电子胎心监护减速的描述，正确的有

- A. 早期减速最低点与宫缩峰值同时出现 ✅
- B. 晚期减速提示胎盘灌注不足 ✅
- C. 变异减速多为脐带受压所致 ✅
- D. 变异减速的典型曲线呈'双肩峰' ✅
- E. 晚期减速最低点出现在宫缩峰值之前

答案：ABCD

> 解析：早期减速最低点与宫缩峰值同时出现，多为胎头受压良性表现。晚期减速最低点落后于宫缩峰值，提示胎盘灌注不足，是危险信号需紧急处理。变异减速与宫缩无固定规律，典型呈'双肩峰'，多提示脐带受压。教材P60。

M4（20题）

60. [A1型题｜记忆] batch034-M4-A1-001

> 模块：M4｜页码：教材P159

足月产是指妊娠满多少周至不足多少周的分娩

- A. 满32周至不足36周
- B. 满36周至不足40周
- C. 满37周至不足42周 ✅
- D. 满38周至不足41周
- E. 满40周至不足44周

答案：C

> 解析：足月产指妊娠满37周至不足42周（259～293日）的分娩；早产指满28周至不足37周；过期产指达到及超过42周。教材P159。

---

61. [A1型题｜记忆] batch034-M4-A1-002

> 模块：M4｜页码：教材P161

关于临产后正常子宫收缩力的特点，错误的是

- A. 节律性是临产的重要标志
- B. 宫缩以宫底部最强最持久
- C. 宫缩起自两侧宫角部位
- D. 宫缩间歇期肌纤维完全恢复到原长度 ✅
- E. 宫缩极期宫腔压力达40～60mmHg

答案：D

> 解析：宫缩的缩复作用使每次收缩后肌纤维缩短变宽，间歇期不能完全恢复到原来长度，经过反复收缩肌纤维越来越短，此为缩复作用。D错在「完全恢复」。教材P160-161。

---

62. [A1型题｜记忆] batch034-M4-A1-003

> 模块：M4｜页码：教材P161

骨盆入口前后径（真结合径）的平均长度是

- A. 9cm
- B. 10cm
- C. 11cm ✅
- D. 12cm
- E. 13cm

答案：C

> 解析：骨盆入口前后径又称真结合径，指从耻骨联合上缘中点至骶岬前缘正中的距离，平均约11cm，胎先露入盆与此径线关系密切。入口横径约13cm，斜径约12.75cm。教材P161。

---

63. [A1型题｜记忆] batch034-M4-A1-004

> 模块：M4｜页码：教材P163

胎头通过产道时采用的最小径线是

- A. 双顶径9.3cm
- B. 枕额径11.3cm
- C. 枕下前囟径9.5cm ✅
- D. 枕颏径13.3cm
- E. 双顶径11.3cm

答案：C

> 解析：胎头以枕下前囟径（前囟中央至枕外隆凸下方，9.5cm）通过产道，以枕额径（11.3cm）衔接。双顶径9.3cm为最大横径，用于判断胎儿大小。枕颏径13.3cm为最大径线。教材P163-164。

---

64. [A1型题｜理解] batch034-M4-A1-005

> 模块：M4｜页码：教材P166

确定临产最可靠的依据是

- A. 规律宫缩伴宫颈扩张 ✅
- B. 阴道少量见红
- C. 胎膜自然破裂
- D. 胎儿下降感
- E. 宫缩强度逐渐增加

答案：A

> 解析：临产的重要标志为规律且逐渐增强的子宫收缩，持续30秒或以上，间歇5～6分钟，同时伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降，用镇静剂不能抑制。见红、胎儿下降感属于先兆临产，胎膜破裂可发生在临产前或临产后。教材P166。

---

65. [A1型题｜理解] batch034-M4-A1-006

> 模块：M4｜页码：教材P167

目前临床上以宫口扩张多少厘米作为进入活跃期的标志

- A. 3cm
- B. 4cm
- C. 5cm ✅
- D. 6cm
- E. 7cm

答案：C

> 解析：活跃期为宫口扩张的加速阶段，可在宫口开至4～5cm即进入活跃期，也可最迟至6cm才进入活跃期。目前以宫口扩张5cm作为进入活跃期的标志，在此之前尽量减少不必要的干预。教材P167。

---

66. [A1型题｜记忆] batch034-M4-A1-007

> 模块：M4｜页码：教材P166

Bishop宫颈成熟度评分法满分为13分，成功率80%的分数区间是

- A. ≤3分
- B. 4～6分
- C. 7～9分 ✅
- D. 10～12分
- E. ＞9分

答案：C

> 解析：Bishop评分法判断宫颈成熟度以估计试产成功率，满分为13分：＞9分均成功，7～9分成功率为80%，4～6分成功率为50%，≤3分均失败。评分的5项指标为宫口开大、宫颈管消退、先露位置、宫颈硬度及宫口位置。教材P166。

---

67. [A1型题｜记忆] batch034-M4-A1-008

> 模块：M4｜页码：教材P172

新生儿Apgar评分中，皮肤颜色全身粉红时的得分为

- A. 0分

- B. 1分
- C. 2分 ✅
- D. 3分
- E. 4分

答案：C

> 解析：Apgar评分由5项体征组成（心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色），每项0～2分。皮肤颜色：0分=全身苍白，1分=身体红四肢青紫，2分=全身粉红。教材P172。

---

68. [A2型题｜理解] batch034-M4-A2-001

> 模块：M4｜页码：教材P166

初产妇，孕39周，夜间出现不规律下腹阵痛，持续约15秒，间歇10～20分钟，无阴道流血流水。清晨症状消失，美拉托宁（镇静剂）后能入睡。最可能的诊断是

- A. 先兆临产 ✅
- B. 正式临产
- C. 先兆早产
- D. 胎盘早剥
- E. 前置胎盘出血

答案：A

> 解析：假临产（不规律宫缩）特点：宫缩频率不一致、持续时间短、间歇时间长且无规律，强度未逐渐增强，常在夜间出现而于清晨消失，不伴有宫颈管缩短、宫口扩张，给予镇静剂能抑制。临产宫缩用镇静剂不能抑制。教材P166。

---

69. [A2型题｜应用] batch034-M4-A2-002

> 模块：M4｜页码：教材P167

初产妇，孕40周，规律宫缩8小时，宫缩持续30秒、间歇5～6分钟，宫口开大2cm，宫颈管消失60%，胎先露S-2，胎心140次/分。合适的处理是

- A. 立即行剖宫产

- B. 人工破膜加速产程
- C. 静滴缩宫素加强宫缩
- D. 继续观察产程，保证休息 ✅
- E. 产钳助产分娩

答案：D

> 解析：初产妇潜伏期一般不超过20小时，该产妇宫缩规律、胎心正常、宫口仅开大2cm，尚在潜伏期正常范围内。应继续观察产程进展，保证产妇休息和营养，避免过早干预。教材P167。

---

70. [A2型题｜应用] batch034-M4-A2-003

> 模块：M4｜页码：教材P170

初产妇，孕39周，宫口开全已2小时，宫缩持续60秒、间歇2分钟，胎头S+3，矢状缝在骨盆出口前后径上，枕部在耻骨联合下方，胎心130次/分。此时最恰当的处理是

- A. 继续等待自然分娩
- B. 立即行剖宫产术
- C. 会阴后-侧切开术+吸引器助产 ✅
- D. 行人工破膜等待
- E. 加大缩宫素用量

答案：C

> 解析：初产妇第二产程不超过3小时（硬膜外者不超过4小时），>2小时需由有经验医师全面评估。本例胎头S+3、矢状缝与出口前后径一致、枕部在耻骨联合下方，已具备阴道助产条件，可行会阴切开后胎头吸引器或产钳助产结束分娩。教材P170。

---

71. [A2型题｜理解] batch034-M4-A2-004

> 模块：M4｜页码：教材P171

初产妇，胎儿娩出后5分钟，阴道少量流血，检查见宫体变硬呈球形、宫底升高达脐上，阴道口外露脐带段自行延长。用手掌尺侧轻压耻骨联合上方，宫体上升而外露脐带不再回缩。此时错误的处理是

- A. 立即牵拉脐带娩出胎盘 ✅

- B. 等待胎盘自然剥离娩出
- C. 确认胎盘已剥离，控制性牵拉脐带协助娩出
- D. 用手进入宫腔剥离胎盘
- E. 注射缩宫素后立即牵拉脐带

答案：A

> 解析：胎盘剥离征象包括：宫体变硬呈球形、宫底升高达脐上、阴道口外露脐带段自行延长、阴道少量流血、掌尺侧压耻骨联合上方子宫下段时宫体上升而外露脐带不再回缩。出现以上征象说明胎盘已完全剥离，应在缩宫素应用下控制性牵拉脐带协助胎盘娩出，而非立即牵拉脐带。教材P171。

---

72. [A2型题｜应用] batch034-M4-A2-005

> 模块：M4｜页码：教材P174

初产妇，孕39周，规律宫缩3小时，宫口开大2cm，疼痛难忍，要求分娩镇痛。平素体健，无麻醉禁忌证。不合适的镇痛方法是

- A. 全身阿片类药物静脉注射 ✅
- B. 硬膜外或腰硬联合麻醉
- C. 吸入笑气镇痛
- D. 针灸穴位镇痛
- E. 导乐陪伴+呼吸调整

答案：A

> 解析：椎管内分娩镇痛是目前首选的分娩镇痛方法，镇痛效果确切。全身阿片类药物静脉注射镇痛效果有限，且可通过胎盘导致新生儿呼吸抑制，不作为首选。教材P174。

---

73. [A2型题｜理解] batch034-M4-A2-006

> 模块：M4｜页码：教材P168

初产妇，孕40周，已进入活跃期，宫口开大6cm，每30分钟听诊胎心1次均正常。胎膜自然破裂后，应立即进行的处理是

- A. 继续常规听诊胎心观察

- B. 立即监测胎心并观察羊水，记录破膜时间 ✅
- C. 阴道检查后即离开产房观察
- D. 立即给予抗菌药物预防感染
- E. 立即再行人工破膜引产

答案：B

> 解析：一旦胎膜破裂，应立即监测胎心，并观察羊水性状（颜色和流出量），记录破膜时间，测量体温。若有胎心异常，应立即阴道检查排除脐带脱垂。破膜后每2小时测量产妇体温，排查绒毛膜羊膜炎，破膜超过12小时尚未分娩才给予抗菌药物预防感染。教材P168。

---

74. [A3型题｜分析] batch034-M4-A3-001

> 模块：M4｜页码：教材P167

初产妇，孕39周，规律宫缩18小时，宫缩持续25秒、间歇7～8分钟，宫口开大3cm，宫颈管消失80%，胎先露S-1，胎心140次/分，未破膜。超声示胎儿估重3200g，骨盆测量无明显异常。该产妇最可能的诊断是

- A. 潜伏期延长 ✅
- B. 活跃期停滞
- C. 第二产程延长
- D. 急产分娩
- E. 活跃期延长

答案：A

> 解析：初产妇潜伏期一般不超过20小时，该产妇规律宫缩18小时、宫口仅开大3cm（尚未达到5cm活跃期标志），属于潜伏期延长。潜伏期延长不是剖宫产指征，可给予哌替啶等镇静剂休息或加强宫缩处理。教材P167。

---

75. [A4型题｜应用] batch034-M4-A4-001

> 模块：M4｜页码：教材P171

初产妇，孕40周，因宫缩乏力使用宫缩剂加强宫缩，宫口开全后2小时行胎头吸引器助产娩出一男婴，体重4000g。胎儿前肩娩出后，应立即采取的措施是

- A. 立即牵拉脐带娩出胎盘
- B. 缩宫素10～20U加入生理盐水静滴 ✅
- C. 等待胎盘自然剥离后娩出
- D. 双手持续按摩子宫底
- E. 立即行宫腔探查手术

答案：B

> 解析：第三产程在胎儿前肩娩出后应将缩宫素10～20U稀释于250～500ml生理盐水中静脉快速滴注，并控制性牵拉脐带，确认胎盘已完全剥离后协助胎盘胎膜完整娩出。该产妇胎儿较大、产程偏长，有产后出血高危因素，预防性使用缩宫素尤为重要。教材P171。

---

76. [B1型题｜理解] batch034-M4-B1-001

> 模块：M4｜页码：教材P165

枕左前位分娩时，胎头为适应中骨盆前后径长、横径短的特点，使枕部向母体中线方向旋转45度，使矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致。该动作称为

- A. 胎头衔接
- B. 胎头俯屈
- C. 胎头内旋转 ✅
- D. 胎头仰伸
- E. 复位及外旋转

答案：C

> 解析：内旋转是胎头下降至骨盆底遇到阻力时，为适应中骨盆前后径长、横径短的特点，枕部向母体中线方向旋转45度达耻骨联合后方，使矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致的动作，胎头于第一产程末完成内旋转。教材P165。

---

77. [B1型题｜理解] batch034-M4-B1-002

> 模块：M4｜页码：教材P165

枕左前位分娩时，胎头以枕额径进入骨盆入口，双顶径达坐骨棘水平，该动作称为

- A. 胎头衔接 ✅
- B. 胎头俯屈
- C. 胎头内旋转
- D. 胎头仰伸
- E. 复位及外旋转

答案：A

> 解析：衔接指胎头双顶径进入骨盆入口平面，颅骨的最低点接近或达到坐骨棘水平。胎头呈半俯屈状态以枕额径进入骨盆入口，矢状缝多在骨盆入口右斜径上。部分初产妇在预产期前1～2周衔接，经产妇多在临产后才衔接。教材P165。

---

78. [X型题｜理解] batch034-M4-X1-001

> 模块：M4｜页码：教材P159

参与分娩启动的机制包括

- A. 炎症反应（母胎界面非感染性炎症） ✅
- B. 前列腺素合成增加诱发宫缩、促宫颈成熟 ✅
- C. 缩宫素直接及间接途径诱发宫缩 ✅
- D. 子宫容量增大及胎先露压迫宫颈部机械性刺激 ✅
- E. 孕激素水平升高增强子宫收缩力

答案：ABCD

> 解析：分娩启动是多因素综合作用的结果。炎症反应（母胎界面免疫微环境改变、中性粒细胞和巨噬细胞趋化浸润）；内分泌因素（PG合成增加诱发宫缩、促宫颈成熟、上调缩宫素受体；雌激素促PG产生、促肌动蛋白蓄积；缩宫素直接或间接诱发宫缩）；机械性刺激（子宫容量增大、胎先露压迫宫颈部Frankenhauser神经丛）。孕激素的作用是抑制宫缩、维持妊娠，而非增强宫缩。教材P159-160。

---

79. [X型题｜应用] batch034-M4-X2-001

> 模块：M4｜页码：教材P160

决定分娩能否顺利进行的因素包括

- A. 产力（宫缩、腹压及肛提肌收缩力） ✅
- B. 产道（骨产道及软产道） ✅
- C. 胎儿（大小、胎位及有无畸形） ✅
- D. 产妇（社会心理因素） ✅
- E. 新生儿（出生性别）

答案：ABCD

> 解析：决定分娩的四因素是产力、产道、胎儿及社会心理因素。产力包括子宫收缩力（主要产力）、腹壁肌和膈肌收缩力（腹压）及肛提肌收缩力；产道包括骨产道（真骨盆）和软产道（子宫下段、宫颈、阴道及盆底软组织）；胎儿因素包括大小、胎位及有无畸形；产妇精神心理因素可影响产力。新生儿性别与分娩无关。教材P160。

M5（20题）

80. [A1型题｜记忆] batch034-M5-A1-001

> 模块：M5｜页码：教材P175

异常分娩（难产）最常见的原因是

- A. 产力因素异常
- B. 产道因素异常
- C. 胎儿因素异常
- D. 社会心理因素
- E. 产力、产道及胎儿因素综合 ✅

答案：E

> 解析：异常分娩最常见为产力、产道及胎儿因素，三者相互影响且互为因果。骨盆狭窄可导致胎位异常及宫缩乏力，宫缩乏力亦可引起胎位异常。教材P175。

---

81. [A1型题｜理解] batch034-M5-A1-002

> 模块：M5｜页码：教材P176

关于产程异常的诊断标准，错误的是

- A. 初产妇潜伏期超过20小时为潜伏期延长
- B. 活跃期扩张＜0.5cm/h为活跃期延长
- C. 初产妇第二产程超过3小时为第二产程延长
- D. 初产妇第二产程超过2小时须经验医师接产 ✅
- E. 活跃期停滞指宫口停止扩张达4小时以上

答案：D

> 解析：初产妇第二产程超过1小时即应关注产程进展，超过2小时必须由有经验的医师进行母胎情况全面评估，而非「超过2小时才需评估」。初产妇>3小时（硬膜外>4小时）为第二产程延长。教材P167、P176。

---

82. [A1型题｜理解] batch034-M5-A1-003

> 模块：M5｜页码：教材P178

协调性子宫收缩乏力（低张性）的特点是

- A. 宫缩节律性、对称性、极性正常，仅收缩力弱 ✅
- B. 子宫收缩失去正常节律，兴奋点来自子宫下段
- C. 宫缩间歇期子宫不能很好松弛
- D. 产妇持续腹痛、腹部拒按
- E. 宫缩极性倒置，宫底部弱于子宫下段

答案：A

> 解析：协调性宫缩乏力又称低张性宫缩乏力，宫缩具有正常节律性、对称性和极性，但收缩力弱，宫腔压力低（<180 Montevideo单位），宫缩<2次/10分钟，持续时间短，间歇期长。B、C、D、E描述的是不协调性宫缩乏力的特点。教材P178。

---

83. [A1型题｜理解] batch034-M5-A1-004

> 模块：M5｜页码：教材P179

关于不协调性子宫收缩乏力的处理，错误的是

- A. 给予哌替啶或吗啡使产妇充分休息
- B. 未恢复协调性前严禁使用缩宫剂
- C. 首选缩宫素静滴加强宫缩 ✅
- D. 伴胎儿窘迫或头盆不称时考虑剖宫产
- E. 休息后多可转为协调性宫缩

答案：C

> 解析：不协调性宫缩乏力（高张性）宫缩失去正常节律性、对称性和极性，兴奋点来自子宫下段，间歇期子宫不能松弛。处理原则是调节子宫收缩，给予哌替啶100mg或吗啡10mg肌注，休息后多可转为协调性。未恢复协调性前严禁使用缩宫剂，否则加重宫缩不协调。教材P179。

---

84. [A1型题｜记忆] batch034-M5-A1-005

> 模块：M5｜页码：教材P179

急产是指总产程不足

- A. 1小时
- B. 2小时
- C. 3小时 ✅
- D. 4小时
- E. 5小时

答案：C

> 解析：协调性宫缩过强且产道无阻力时，总产程不足3小时称为急产，以经产妇多见。急产可致软产道裂伤、新生儿颅内出血、感染及骨折等。教材P179。

---

85. [A1型题｜记忆] batch034-M5-A1-006

> 模块：M5｜页码：教材P180

骨盆入口平面绝对性狭窄是指对角径

- A. ≤9.5cm ✅
- B. ≤10.0cm

- C. ≤10.5cm
- D. ≤11.0cm
- E. ≤11.5cm

答案：A

> 解析：骨盆入口平面狭窄以对角径（正常值12.5～13cm）分为3级：Ⅰ级临界性11.5cm；Ⅱ级相对性10.0～11.0cm；Ⅲ级绝对性≤9.5cm，需剖宫产。相对性狭窄且胎儿不大、产力胎位胎心正常时可严密试产。教材P180。

---

86. [A1型题｜理解] batch034-M5-A1-007

> 模块：M5｜页码：教材P183

胎头跨耻征阳性是指

- A. 胎头低于耻骨联合平面
- B. 胎头与耻骨联合在同一平面
- C. 胎头高于耻骨联合平面 ✅
- D. 胎头双顶径已入盆
- E. 胎头矢状缝与骨盆入口前后径一致

答案：C

> 解析：胎头跨耻征检查：孕妇排空膀胱仰卧、双腿伸直，一手置耻骨联合上方，另一手将胎头向盆腔方向推压。胎头低于耻骨联合平面为阴性（已衔接）；与耻骨联合平面相平为可疑阳性；高于耻骨联合平面为阳性，提示头盆不称可能。跨耻征阳性仅为提示，需结合骨盆分级及试产最终决定分娩方式。教材P183。

---

87. [A1型题｜理解] batch034-M5-A1-008

> 模块：M5｜页码：教材P180

病理性缩复环与子宫痉挛性狭窄环的主要鉴别点是

- A. 是否由宫缩过强引起
- B. 是否随宫缩上升 ✅

- C. 是否引起产程延长
- D. 是否导致胎儿窘迫
- E. 是否出现于经产妇

答案：B

> 解析：病理性缩复环位于子宫下段、随宫缩上升，是先兆子宫破裂的征象，常伴血尿和下段压痛。子宫痉挛性狭窄环位于胎体狭窄部（胎儿颈、腰部），不随宫缩上升，多由精神紧张、过度疲劳或不当使用缩宫剂引起。两者鉴别要点即是否随宫缩上升。教材P180。

---

88. [A2型题｜记忆] batch034-M5-A2-001

> 模块：M5｜页码：教材P179

初产妇，孕40周，规律宫缩20小时，宫口开大6cm，宫缩持续20秒、间歇7～8分钟，强度弱，胎心140次/分，胎头S-1，已破膜，羊水清。骨盆测量无明显异常，胎位LOA。首选的处理是

- A. 立即行剖宫产
- B. 静滴缩宫素加强宫缩 ✅
- C. 肌注哌替啶镇静休息
- D. 产钳助产分娩
- E. 继续等待自然宫缩

答案：B

> 解析：该产妇宫口已开大6cm进入活跃期，但宫缩持续仅20秒、间歇7～8分钟，且强度弱，为协调性宫缩乏力（低张性）。已破膜、无头盆不称、胎位正常、胎心好，应首选缩宫素静滴加强宫缩。教材P179。

---

89. [A2型题｜应用] batch034-M5-A2-002

> 模块：M5｜页码：教材P179

初产妇，孕38周，临产后出现持续性腹痛、腹部拒按，宫缩间歇期子宫仍不能完全松弛，宫口扩张缓慢，胎心偏快。此时最恰当的处理是

- A. 人工破膜加速产程

- B. 缩宫素静滴加强宫缩
- C. 立即行剖宫产术
- D. 哌替啶100mg肌注调节宫缩 ✅
- E. 阴道检查后产钳助产

答案：D

> 解析：该产妇表现为不协调性宫缩乏力（高张性）：持续腹痛、腹部拒按、宫缩间歇期子宫不能松弛、宫口扩张缓慢。处理原则是调节宫缩，给予哌替啶100mg或吗啡10mg肌注，休息后多可转为协调性。未恢复协调性前严禁使用缩宫剂。教材P179。

---

90. [A2型题｜应用] batch034-M5-A2-003

> 模块：M5｜页码：教材P184

初产妇，孕39周，临产16小时，宫口开全2小时，胎头S+1，坐骨结节间径7.0cm，出口后矢状径7.5cm，两者之和14.5cm。胎心140次/分。最恰当的处理是

- A. 继续等待自然分娩
- B. 产钳助产
- C. 胎头吸引器助产
- D. 立即剖宫产 ✅
- E. 缩宫素加强宫缩

答案：D

> 解析：出口横径（坐骨结节间径）+出口后矢状径>15cm时中等大小足月胎头可通过后三角区经阴道分娩。本例二者之和为14.5cm，小于15cm，提示足月胎儿经阴道分娩困难，不宜阴道试产。应行剖宫产结束分娩。教材P184。

---

91. [A2型题｜理解] batch034-M5-A2-004

> 模块：M5｜页码：教材P186

初产妇，孕40周，临产后16小时，宫口开全已1.5小时，产妇自觉肛门坠胀及排便感强烈，过早屏气，宫颈前唇水肿。阴道检查：矢状缝位于骨盆左斜径上，前囟在骨盆右前方，后囟在骨盆左侧后方。最可能的诊断是

- A. 枕左前位
- B. 枕左后位 ✅
- C. 枕右前位
- D. 枕右后位
- E. 高直位

答案：B

> 解析：根据阴道检查，后囟在骨盆左后方，矢状缝位于骨盆左斜径上，前囟在骨盆右前方，符合枕左后位（LOA时为枕左前位，后囟在左前方）。持续性枕后位表现为产妇肛门坠胀、早用腹压、宫颈前唇水肿，是头位难产最常见原因。教材P186。

---

92. [A2型题｜应用] batch034-M5-A2-005

> 模块：M5｜页码：教材P197

初产妇，孕40周，胎儿娩出胎头后，前肩嵌顿于耻骨联合上方，胎颈回缩，出现「乌龟征」。此时首选的助产手法是

- A. 按压宫底协助前肩娩出
- B. 屈大腿法（McRoberts法） ✅
- C. 立即行剖宫产手术
- D. 牵拉胎头旋转胎肩
- E. 会阴正中切开扩大出口

答案：B

> 解析：肩难产指胎头娩出后前肩嵌顿于耻骨联合上方，常规助产无法娩出双肩。首选屈大腿法（McRoberts法）：让产妇双腿极度屈曲贴近腹部，减小骨盆倾斜度，使嵌顿的前肩松解。同时可联合耻骨上加压法。切忌按压宫底，否则加重嵌顿或致子宫破裂。教材P197。

---

93. [A2型题｜应用] batch034-M5-A2-006

> 模块：M5｜页码：教材P192

初产妇，孕36周，臀先露，决定剖宫产分娩。下列不属于臀先露择期剖宫产指征的是

- A. 估测胎儿体重3500g
- B. 骨盆入口明显狭窄
- C. 足先露（不完全臀先露）
- D. 3000g单臀骨盆正常 ✅
- E. 胎头呈仰伸位

答案：D

> 解析：臀先露择期剖宫产指征包括：骨盆狭窄、瘢痕子宫、估测胎儿体重>3500g、胎儿生长受限、胎儿窘迫、胎头仰伸位、有难产史、妊娠合并症、脐带先露和不完全臀先露（足先露）、无臀先露助产经验者。胎儿估重3000g、骨盆正常、单臀先露且具备臀助产经验者可考虑阴道分娩。教材P192。

---

94. [A3型题｜分析] batch034-M5-A3-001

> 模块：M5｜页码：教材P206

经产妇，孕39周，因骨盆狭窄临产18小时，宫缩强而频，产妇烦躁不安，下腹剧痛难忍，腹部检查见脐平处有一环形凹陷，子宫下段压痛明显，排尿困难，导尿见血尿，胎心160次/分。最可能的诊断是

- A. 子宫痉挛性狭窄环
- B. 先兆子宫破裂 ✅
- C. 完全性子宫破裂
- D. 胎盘早剥出血
- E. 协调性宫缩过强（急产）

答案：B

> 解析：先兆子宫破裂常见于宫缩过强合并产道梗阻（如骨盆狭窄），典型表现：病理性缩复环（随宫缩上升的环状凹陷）、子宫下段压痛、血尿、胎心率异常。本例骨盆狭窄+宫缩过强+病理性缩复环+血尿，符合先兆子宫破裂。应立即抑制宫缩并尽快手术。教材P179、P206。

---

95. [A4型题｜应用] batch034-M5-A4-001

> 模块：M5｜页码：教材P176

初产妇，孕40周，规律宫缩12小时，宫口开大5cm后停滞4小时，已人工破膜，羊水清，宫缩持续30秒、间歇5～6分钟，强度中等，评估无头盆不称，胎心140次/分。予缩宫素静滴加强宫缩后2小时宫口仍无进展仍为5cm。下一步最恰当的处理是

- A. 继续加大缩宫素用量观察
- B. 行剖宫产术结束分娩 ✅
- C. 产钳助产分娩
- D. 改行人工破膜
- E. 阴道检查后等待自然分娩

答案：B

> 解析：活跃期停滞指破膜且宫口≥5cm后，宫缩正常停止扩张≥4小时或宫缩欠佳≥6小时。该产妇破膜后宫口5cm停滞4小时，缩宫素加强2小时后仍无进展，提示存在头盆不称或胎位异常可能，继续试产意义不大，应行剖宫产结束分娩。教材P176。

---

96. [B1型题｜记忆] batch034-M5-B1-001

> 模块：M5｜页码：教材P178

临产后宫缩节律性、对称性、极性正常，但收缩力弱，宫腔压力低，持续时间短，间歇期长。该宫缩异常类型为

- A. 协调性宫缩乏力（低张性） ✅
- B. 不协调性宫缩乏力（高张性）
- C. 协调性宫缩过强
- D. 强直性子宫收缩
- E. 子宫痉挛性狭窄环

答案：A

> 解析：协调性宫缩乏力（低张性）宫缩具有正常节律性、对称性和极性，仅收缩力弱，宫腔压力<180 Montevideo单位，宫缩<2次/10分钟，持续时间短，间歇期长。处理原则是加强宫缩。教材P178。

---

97. [B1型题｜记忆] batch034-M5-B1-002

> 模块：M5｜页码：教材P179

临产后宫缩失去正常节律性，兴奋点来自子宫下段，宫缩间歇期子宫不能完全松弛，产妇持续腹痛、腹部拒按。该宫缩异常类型为

- A. 协调性宫缩乏力（低张性）
- B. 不协调性宫缩乏力（高张性） ✅
- C. 协调性宫缩过强
- D. 强直性子宫收缩
- E. 子宫痉挛性狭窄环

答案：B

> 解析：不协调性宫缩乏力（高张性）宫缩失去正常节律性、对称性尤其极性，兴奋点来自子宫下段一处或多处，由下而上扩散为无效宫缩，宫缩间歇期子宫不能很好松弛。处理原则是调节宫缩，给予哌替啶或吗啡休息，严禁先使用缩宫剂。教材P178-179。

---

98. [X型题｜理解] batch034-M5-X1-001

> 模块：M5｜页码：教材P175

关于异常分娩病因的叙述，正确的有

- A. 产力、产道、胎儿因素可相互影响、互为因果 ✅
- B. 子宫收缩乏力可致产程延长或停滞 ✅
- C. 骨盆狭窄是骨产道异常中最常见的类型 ✅
- D. 胎头位置异常是导致头位难产的首要原因 ✅
- E. 单纯社会心理因素不会导致难产

答案：ABCD

> 解析：异常分娩的病因包括产力异常、产道异常和胎儿因素，三者相互影响互为因果。宫缩乏力可致产程延长或停滞；骨盆狭窄是骨产道异常中最常见类型；胎头位置异常（持续性枕后位、枕横位等）是导致头位难产的首要原因。社会心理因素也是决定分娩的因素之一，恐惧和紧张可导致宫缩乏力、产程延长。教材P175。

---

99. [X型题｜理解] batch034-M5-X2-001

> 模块：M5｜页码：教材P197

肩难产的处理措施包括

- A. 屈大腿法（McRoberts法） ✅
- B. 耻骨联合上加压法 ✅
- C. 按压宫底协助前肩娩出
- D. 旋肩法（Rubin或Woods） ✅
- E. 尽量牵拉胎头娩出胎肩

答案：ABD

> 解析：肩难产的处理原则：停止向下牵拉胎头，按HELPERR流程依次执行。屈大腿法（McRoberts法）首选，让产妇双腿极度屈曲贴近腹部减小骨盆倾斜度；耻骨上加压法助手在耻骨联合上方压迫前肩；旋肩法（Rubin法压胎儿肩胛使肩内收、Woods法旋转后肩180度）。严禁按压宫底（加重嵌顿）和过度牵拉胎头（致臂丛损伤）。教材P197。

M6（20题）

100. [A1型题｜记忆] batch034-M6-A1-001

> 模块：M6｜页码：教材P198

产后出血是指胎儿娩出后24小时内，阴道分娩者出血量达到或超过

- A. 300ml
- B. 500ml ✅
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 1500ml

答案：B

> 解析：产后出血指胎儿娩出后24小时内，阴道分娩者出血量≥500ml，剖宫产者≥1000ml，或失血后伴低血容量症状或体征；严重产后出血指出血量≥1000ml。产后出血是导致我国孕产妇死亡的首位原因。教材P198。

101. [A1型题｜记忆] batch034-M6-A1-002

> 模块：M6｜页码：教材P198

产后出血最常见的原因是

- A. 子宫收缩乏力 ✅
- B. 软产道裂伤
- C. 凝血功能障碍
- D. 胎盘滞留
- E. 子宫破裂

答案：A

> 解析：子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤及凝血功能障碍是产后出血的主要原因，其中子宫收缩乏力最常见。教材P198。

---

102. [A1型题｜记忆] batch034-M6-A1-003

> 模块：M6｜页码：教材P199

产后出血产妇休克指数（脉率/收缩压）为1.5时，估计失血量约占血容量的

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30% ✅
- D. 50%
- E. 70%

答案：C

> 解析：产妇休克指数正常范围为0.7～0.9，提示血容量正常；SI=1.0时失血量约20%（1000ml）；SI=1.5时失血量约30%（1500ml）；SI=2.0时失血量≥50%（≥2500ml）。教材P199。

---

103. [A1型题｜记忆] batch034-M6-A1-004

> 模块：M6｜页码：教材P198

胎盘滞留是指胎儿娩出后，胎盘超过多长时间仍未娩出

- A. 10分钟
- B. 30分钟 ✅
- C. 45分钟
- D. 60分钟
- E. 90分钟

答案：B

> 解析：胎盘多在胎儿娩出后15分钟内娩出，若30分钟后仍不排出为胎盘滞留，将导致出血。常见原因包括膀胱充盈、胎盘嵌顿和胎盘剥离不全。教材P198。

---

104. [A1型题｜理解] batch034-M6-A1-005

> 模块：M6｜页码：教材P200

关于会阴裂伤分度的描述，错误的是

- A. Ⅰ度指会阴部皮肤及阴道入口黏膜撕裂
- B. Ⅱ度裂伤已达会阴体筋膜及肌层
- C. Ⅲ度裂伤肛门外括约肌断裂，直肠黏膜尚完整
- D. Ⅳ度肛门、直肠和阴道完全贯通
- E. Ⅲ度裂伤时肛门、直肠和阴道完全贯通 ✅

答案：E

> 解析：会阴裂伤分4度：Ⅰ度为皮肤及阴道入口黏膜撕裂；Ⅱ度达会阴体筋膜及肌层；Ⅲ度向会阴深部扩展、肛门外括约肌已断裂而直肠黏膜尚完整；Ⅳ度肛门、直肠和阴道完全贯通，直肠肠腔外露，出血量可不多。“肛门、直肠和阴道完全贯通”是Ⅳ度而非Ⅲ度。教材P200。

---

105. [A1型题 | 记忆] batch034-M6-A1-006

> 模块：M6 | 页码：教材P204

典型羊水栓塞的三联征是

- A. 高热、寒战、休克
- B. 抽搐、昏迷、无尿
- C. 低氧血症、低血压、凝血功能障碍 ✅
- D. 胸痛、咯血、呼吸困难
- E. 腹痛、阴道流血、胎心消失

答案：C

> 解析：典型羊水栓塞以骤然出现的低氧血症、低血压（血压与失血量不符合）和凝血功能障碍为特征，又称羊水栓塞三联征。教材P204。

---

106. [A1型题 | 记忆] batch034-M6-A1-007

> 模块：M6 | 页码：教材P206

先兆子宫破裂的重要体征是在子宫体部与子宫下段之间形成

- A. 生理性缩复环
- B. 病理性缩复环 ✅
- C. Coffee环
- D. 加德纳环
- E. 腹白线疝环

答案：B

> 解析：先兆子宫破裂时因胎先露部下降受阻、子宫收缩过强，子宫体部肌肉增厚变短、子宫下段肌肉变薄拉长，两者间形成环状凹陷，称病理性缩复环，随产程进展逐渐上升平脐或脐上，压痛明显。教材P206。

---

107. [A1型题｜理解] batch034-M6-A1-008

> 模块：M6｜页码：教材P206

关于完全性子宫破裂的临床表现，错误的是

- A. 突感下腹撕裂样剧痛，宫缩骤然停止
- B. 全腹压痛、反跳痛
- C. 腹壁下可清楚扪及胎体
- D. 胎心胎动均已消失
- E. 阴道检查胎先露下降、宫口开大 ✅

答案：E

> 解析：完全性子宫破裂累及子宫壁全层、宫腔与腹腔相通，产妇突感撕裂样剧痛后宫缩骤停，随后出现全腹持续性疼痛及低血容量性休克征象，腹壁下可清楚扪及胎体，胎心胎动消失；阴道检查可有鲜血流出、胎先露部升高、开大的宫颈口缩小。教材P206。

---

108. [A2型题｜应用] batch034-M6-A2-001

> 模块：M6｜页码：教材P199

初产妇，胎儿胎盘娩出后阴道流血较多，检查宫底升高、子宫质软、轮廓不清。按摩子宫并应用宫缩剂后子宫变硬、流血减少。出血原因首先考虑

- A. 子宫收缩乏力 ✅
- B. 软产道裂伤
- C. 凝血功能障碍
- D. 胎盘植入
- E. 子宫破裂

答案：A

> 解析：子宫收缩乏力时宫底升高、子宫质软、轮廓不清、阴道流血多；按摩子宫及应用宫缩剂后子宫变硬、流血减少或停止，可确诊为子宫收缩乏力。教材P199。

---

109. [A2型题｜理解] batch034-M6-A2-002

> 模块：M6｜页码：教材P200

缩宫素治疗产后出血时，24小时内用药总量应控制在

- A. 20U以内
- B. 40U以内
- C. 60U以内 ✅
- D. 80U以内
- E. 100U以内

答案：C

> 解析：缩宫素是预防和治疗产后出血的一线药物，稀释后持续静脉滴注5～10U/h，也可10U肌内注射或子宫肌层注射，但24小时内总量应控制在60U内。教材P200。

---

110. [A2型题｜理解] batch034-M6-A2-003

> 模块：M6｜页码：教材P199

徒手剥离胎盘时发现胎盘与宫壁难以剥离，牵拉脐带时子宫壁与胎盘一起内陷。此时不应进行的操作是

- A. 立即停止剥离胎盘
- B. 根据出血情况选择保守或子宫切除
- C. 彩色多普勒超声监测胎盘周围血流
- D. 强行剥离粘连胎盘 ✅
- E. 评估出血量及生命体征

答案：D

> 解析：牵拉脐带时子宫壁与胎盘一起内陷提示胎盘植入，应立即停止剥离；强行剥离可造成大量出血甚至子宫穿孔。应根据出血情况及胎盘剥离面积行保守治疗（局部切除、动脉栓塞、米非司酮、甲氨蝶呤等）或子宫切除术。教材P199。

---

111. [A2型题｜应用] batch034-M6-A2-004

> 模块：M6｜页码：教材P205

经产妇，第二产程中突现呼吸困难、发绀、烦躁，血压由130/80mmHg骤降至70/40mmHg，随即切口渗血、阴道流血不凝。抢救时除呼吸循环支持外，纠正凝血功能障碍应采取

- A. 首选肝素抗凝治疗
- B. 及时启动大量输血方案并抗纤溶治疗 ✅
- C. 单用氨甲环酸即可
- D. 等待实验室确诊后处理
- E. 输注全血后不予其他成分

答案：B

> 解析：羊水栓塞并发DIC发生率极高，应早期评估并动态监测凝血功能，及时、快速启动大量输血方案（红细胞悬液、大量新鲜冰冻血浆、冷沉淀、纤维蛋白原、血小板等），同时可行抗纤溶治疗，不推荐肝素治疗。教材P205。

---

112. [A2型题｜应用] batch034-M6-A2-005

> 模块：M6｜页码：教材P207

初产妇，临产16小时，宫缩强直，下腹剧痛难忍，脐平处见病理性缩复环且压痛明显，排尿困难伴血尿，胎心170次/分。正确的处理是

- A. 立即抑制子宫收缩并尽快手术 ✅
- B. 等待宫口开全阴道助产
- C. 静滴缩宫素加强宫缩
- D. 继续观察产程进展
- E. 行人工破膜加速产程

答案：A

> 解析：本例为典型先兆子宫破裂（强直性宫缩、病理性缩复环上升压痛、血尿、胎心率异常）。应立即抑制子宫收缩并尽快手术，可采用全身麻醉；严禁用缩宫素加强宫缩。教材P207。

---

113. [A2型题｜理解] batch034-M6-A2-006

> 模块：M6｜页码：教材P199

初产妇，阴道分娩后1小时，面色苍白、脉搏细数、血压90/55mmHg等低血容量表现明显，但阴道流血不多，伴阴道内坠胀疼痛。最可能的诊断是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 产道血肿（隐匿性损伤） ✅
- C. 凝血功能障碍
- D. 急性羊水栓塞
- E. 产后子宫收缩痛

答案：B

> 解析：低血容量症状明显、伴阴道疼痛而阴道流血不多，应考虑隐匿性软产道损伤如阴道血肿；触及张力大、压痛明显、有波动感的包块且表面皮肤颜色改变者为阴道壁血肿。教材P199。

---

114. [A3型题｜应用] batch034-M6-A3-001

> 模块：M6｜页码：教材P202

女，26岁。足月分娩过程中突然呼吸困难、发绀、血压下降、全身抽搐、昏迷，抢救无效死亡。尸体解剖时，肺小动脉和毛细血管内最可能的发现是

- A. 角化上皮及胎毛等羊水成分 ✅
- B. 脂滴及脂肪颗粒
- C. 气泡及气栓成分
- D. 血栓及血液凝块
- E. 肿瘤细胞栓子

答案：A

> 解析：本例为羊水栓塞。分娩过程中宫内压增高可将羊水压入子宫壁破裂的静脉窦，经血循环进入肺动脉及毛细血管；确诊羊水栓塞的病理依据是镜下见到肺小动脉、毛细血管内有羊水成分，如角化鳞状上皮、胎毛、胎脂、胎粪、黏液等。脂滴、气泡、血栓分别为脂肪栓塞、气体栓塞、血栓栓塞的病理特点。教材P202。［源:考研真题 GS-2011-045］

---

115. [A4型题｜分析] batch034-M6-A4-001

> 模块：M6｜页码：教材P200

产妇，剖宫产术中胎盘娩出后子宫收缩乏力性大出血，经按摩子宫、持续静滴缩宫素、卡前列素氨丁三醇肌注后仍出血不止，宫腔纱条填塞无效，患者血压85/50mmHg。下一步最适宜的处理是

- A. 立即行子宫压缩缝合术 ✅
- B. 继续观察出血情况
- C. 直接行全子宫切除作为首选
- D. 增加缩宫素剂量至80U/h
- E. 口服米索前列醇观察

答案：A

> 解析：子宫压缩缝合术适用于经宫缩剂和按压子宫无效者，尤其适用于宫缩乏力导致的产后出血，常用B-Lynch缝合法；仍无效可结扎盆腔血管或行经导管动脉栓塞术；经积极抢救无效、危及产妇生命时才尽早行子宫切除术，不应作为首选。教材P200。

---

116. [B1型题｜应用] batch034-M6-B1-001

> 模块：M6｜页码：教材P199

胎儿娩出后立即发生阴道流血，色鲜红。首先考虑的出血原因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 软产道裂伤 ✅
- C. 凝血功能障碍
- D. 胎盘滞留
- E. 子宫胎盘卒中

答案：B

> 解析：胎儿娩出后立即发生阴道流血、鲜红色，应考虑软产道裂伤。教材P199。

---

117. [B1型题｜理解] batch034-M6-B1-002

> 模块：M6｜页码：教材P199

胎儿娩出后数分钟出现阴道流血，色暗红，胎盘尚未娩出。首先考虑的出血原因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 软产道裂伤
- C. 凝血功能障碍
- D. 胎盘因素 ✅
- E. 子宫胎盘卒中

答案：D

> 解析：胎儿娩出后数分钟出现阴道流血、暗红色，应考虑胎盘因素（胎盘部分剥离、嵌顿、粘连或植入、残留等）。教材P199。

---

118. [X型题｜理解] batch034-M6-X1-001

> 模块：M6｜页码：教材P200

宫缩乏力性产后出血的处理措施包括

- A. 按摩或按压子宫底部 ✅
- B. 应用缩宫素、前列腺素类宫缩剂 ✅
- C. 宫腔填塞（纱条或球囊） ✅
- D. 子宫压缩缝合（B-Lynch法） ✅
- E. 无论出血多少首选全子宫切除

答案：ABCD

> 解析：宫缩乏力性产后出血的处理依次为按摩/按压子宫、应用宫缩剂（缩宫素为一线，麦角新碱禁用于妊娠期高血压疾病者）、宫腔填塞、子宫压缩缝合术、结扎盆腔血管、经导管动脉栓塞术，最后才是切除子宫以挽救生命。教材P200。

---

119. [X型题｜理解] batch034-M6-X2-001

> 模块：M6｜页码：教材P204

羊水栓塞的治疗措施包括

- A. 呼吸支持（面罩、气管插管、ECMO） ✅
- B. 血管活性药物维持血流动力学稳定 ✅
- C. 尽早大剂量糖皮质激素抗过敏 ✅
- D. 大量输血方案纠正凝血功能障碍 ✅
- E. 常规给予肝素抗凝治疗

答案：ABCD

> 解析：羊水栓塞治疗原则为维持呼吸循环等生命体征及保护器官功能：呼吸支持可选面罩、无创通气、气管插管甚至ECMO；循环支持用去甲肾上腺素、多巴酚丁胺等；可尝试尽早大剂量糖皮质激素（氢化可的松500～1000mg/d）；纠正凝血功能障碍采用大量输血方案并抗纤溶，不推荐肝素治疗。教材P204。

M7（20题）

120. [A1型题｜记忆] batch034-M7-A1-001

> 模块：M7｜页码：教材P76

女性，35岁。习惯性流产，经检查确诊为双角子宫，无法足月妊娠。患者要求医生对此保密，否则会破坏她的婚姻。医生的做法能够得到伦理学辩护的是

- A. 保护患者隐私，不透露该信息给其丈夫 ✅
- B. 拒绝患者的要求，因为该患者的丈夫有知情权
- C. 拒绝患者的要求，因为医生应该说真话
- D. 拒绝患者的要求，因为生育是夫妻双方的权利
- E. 拒绝患者的要求，因为配偶有法定代理权

答案：A

> 解析：[源:考研真题 GS-2022-112] 患者享有隐私权，医师对患者的病情负有保密义务；未经患者同意，不应将病情信息告知其配偶。

121. [A1型题 | 记忆] batch034-M7-A1-002

> 模块：M7 | 页码：教材P76

习惯性流产是指与同一性伴侣连续自然流产达到一定次数。该次数是

- A. 1次及以上
- B. 2次及以上
- C. 3次及以上 ✅
- D. 4次及以上
- E. 5次及以上

答案：C

> 解析：习惯性流产指与同一性伴侣连续自然流产3次及以上（美国生殖医学会定义为≥2次妊娠失败，但国内教材仍以3次为标准）。早期习惯性流产常见原因包括胚胎染色体异常、黄体功能不足、抗磷脂综合征等；晚期常见原因包括宫颈机能不全、子宫畸形等。教材P76。［源:考研真题 GS-2022-112］

---

122. [A1型题 | 理解] batch034-M7-A1-003

> 模块：M7 | 页码：教材P78

异位妊娠最常发生的部位是

- A. 输卵管间质部
- B. 输卵管壶腹部 ✅
- C. 输卵管峡部
- D. 卵巢内
- E. 腹腔内

答案：B

> 解析：异位妊娠是受精卵在子宫体腔以外着床，以输卵管妊娠最常见（约占95%），其中壶腹部约占78%，其次为峡部、伞部、间质部。卵管妊娠破裂或流产是妇科常见急腹症。教材P78。

---

123. [A1型题｜理解] batch034-M7-A1-004

> 模块：M7｜页码：教材P79

关于输卵管妊娠破裂与流产，错误的是

- A. 输卵管峡部妊娠最易发生破裂
- B. 输卵管壶腹部妊娠常表现为流产型
- C. 输卵管间质部妊娠破裂最晚、最凶险
- D. 输卵管妊娠流产型出血量一般少于破裂型
- E. 陈旧性宫外孕指破裂后大量出血短期内休克 ✅

答案：E

> 解析：输卵管峡部肌层薄、管腔狭窄，易发生破裂（约6周）；壶腹部管腔较宽，常发生输卵管妊娠流产（8～12周），出血量一般少于破裂型；间质部肌层厚、血运丰富，破裂最晚（12～16周）、最凶险。陈旧性宫外孕指输卵管妊娠流产或破裂后病程长、反复内出血形成的盆腔血肿机化与周围组织粘连。教材P79。［源:考研真题 GS-1999-078］

---

124. [A1型题｜记忆] batch034-M7-A1-005

> 模块：M7｜页码：教材P88

妊娠期高血压疾病的基本病理生理变化是

- A. 全身小动脉痉挛 ✅
- B. 血液高凝状态
- C. 水钠潴留明显
- D. 胎盘缺血-再灌注损伤
- E. 毛细血管通透性增加

答案：A

> 解析：妊娠期高血压疾病的基本病理生理变化是全身小血管痉挛和血管内皮损伤，导致全身各系统各脏器灌注减少，组织缺血缺氧，严重时可致多器官功能损害。血管内皮损伤使扩血管物质（NO、前列环素）减少、缩血管物质（内皮素、血栓素A2）增加。教材P88。

---

125. [A1型题 | 记忆] batch034-M7-A1-006

> 模块：M7 | 页码：教材P92

应用硫酸镁治疗子痫前期时，最早出现的中毒表现是

- A. 呼吸减慢
- B. 尿量减少
- C. 膝反射消失 ✅
- D. 心率减慢
- E. 血压下降

答案：C

> 解析：硫酸镁是子痫前期-子痫解痉治疗的一线药物，有效治疗浓度为1.8～3.0mmol/L，超过3.5mmol/L可出现中毒。中毒最早表现为膝反射消失，随后出现呼吸减慢（<16次/分）、尿量减少（<17ml/h或<400ml/24h）。抢救时立即停用硫酸镁，缓慢静脉注射10%葡萄糖酸钙10ml。教材P92。

---

126. [A1型题 | 记忆] batch034-M7-A1-007

> 模块：M7 | 页码：教材P100

早产是指妊娠满28周但不足多少周的分娩

- A. 32周
- B. 34周
- C. 35周
- D. 36周
- E. 37周 ✅

答案：E

> 解析：早产指妊娠满28周至不足37周（196～258日）间分娩者，占分娩总数的5%～15%。早产分为自发性早产和治疗性早产。妊娠满37周至不满42周为足月产，妊娠达到或超过42周为过期产。教材P100。

---

127. [A1型题｜理解] batch034-M7-A1-008

> 模块：M7｜页码：教材P145

关于前置胎盘与胎盘早剥的鉴别，错误的是

- A. 前置胎盘典型表现为无痛性反复阴道流血
- B. 胎盘早剥多伴有腹痛
- C. 前置胎盘子宫软、无压痛
- D. 胎盘早剥时出血量与病情严重程度成正比 ✅
- E. 前置胎盘禁行肛门指检

答案：D

> 解析：前置胎盘典型表现为妊娠晚期无诱因、无痛性反复阴道流血，子宫软、无压痛，禁行肛门指检及不必要阴道检查。胎盘早剥典型表现为腹痛伴阴道流血，子宫张力增高、有压痛。胎盘早剥的出血量与病情严重程度不一定成正比——后壁隐性剥离时外出血少但内出血多、病情重，可致DIC、失血性休克。教材P145、P147。

---

128. [A2型题｜应用] batch034-M7-A2-001

> 模块：M7｜页码：教材P81

女，28岁。停经6周，突感下腹撕裂样疼痛2小时，伴肛门坠胀感。查体：血压80/50mmHg，脉搏110次/分，腹部压痛、反跳痛，移动性浊音阳性。妇科检查：宫颈举痛明显，子宫大小正常、有漂浮感，附件区未及明显包块。最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 黄体破裂
- C. 输卵管妊娠破裂 ✅
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 急性盆腔炎

答案：C

> 解析：患者有停经史、突发下腹撕裂样疼痛、肛门坠胀感、血压下降、宫颈举痛、子宫漂浮感，符合输卵管妊娠破裂的典型表现。异位妊娠破裂时内出血积聚于直肠子宫陷凹，刺激腹膜致肛门坠胀感；宫颈举痛为腹膜刺激征；子宫漂浮感提示腹腔内出血量多。黄体破裂多发生在月经后半期，无停经史。教材P81。

129. [A2型题｜理解] batch034-M7-A2-002

> 模块：M7｜页码：教材P76

女，30岁。停经12周，阴道少量流血3日，无腹痛。妇科检查：宫颈口闭，子宫大小与停经孕周相符。血hCG阳性。最可能的诊断是

- A. 难免流产
- B. 先兆流产 ✅
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

答案：B

> 解析：先兆流产指妊娠28周前先出现少量阴道流血，无妊娠物排出，随后出现阵发性下腹痛；妇科检查宫颈口未开、胎膜未破、子宫大小与停经孕周相符。本例宫颈口闭、子宫大小与孕周相符、仅少量阴道流血、无腹痛，符合先兆流产。处理为卧床休息、禁止性生活，必要时予黄体功能支持。教材P76。

---

130. [A2型题｜理解] batch034-M7-A2-003

> 模块：M7｜页码：教材P87

女，32岁。妊娠34周，血压150/95mmHg，尿蛋白（++），无头痛、视力模糊等不适。实验室检查：血小板150×10^9/L，ALT 35U/L，肌酐60μmol/L。该患者最可能的诊断是

- A. 妊娠期高血压
- B. 子痫前期（无严重特征） ✅
- C. 子痫前期（伴严重特征）
- D. 慢性高血压病
- E. HELLP综合征

答案：B

> 解析：妊娠20周后出现血压≥140/90mmHg伴蛋白尿（≥0.3g/24h或随机尿蛋白（+）），定义为子痫前期。本例孕34周、血压150/95mmHg、尿蛋白（++），符合子痫前期诊断。但无严重特征（收缩压≥160或舒张压≥110、血小板<100×10⁹/L、肝酶升正常2倍、肌酐>1.1mg/dl、肺水肿、新发脑部或视觉症状），故为子痫前期（无严重特征）。教材P87。

---

131. [A2型题｜应用] batch034-M7-A2-004

> 模块：M7｜页码：教材P92

女，30岁。妊娠34周，重度子痫前期（合并抗磷脂综合征），予硫酸镁解痉治疗。治疗期间应密切监测的指标中，不包括****

- A. 膝反射检查
- B. 呼吸频率
- C. 24小时尿量
- D. 血清镁离子浓度
- E. 血小板计数 ✅

答案：E

> 解析：硫酸镁治疗期间必须监测：膝反射（最早中毒表现）、呼吸频率（<16次/分提示中毒）、24小时尿量（<400ml或<17ml/h提示中毒）、血清镁离子浓度（有效1.8~3.0mmol/L，>3.5mmol/L中毒）。血小板计数是子痫前期病情评估指标，但非硫酸镁治疗中的特异性监测指标。教材P92。［源:考研真题 GS-2022-056］

---

132. [A2型题｜应用] batch034-M7-A2-005

> 模块：M7｜页码：教材P147

女，33岁。妊娠32周，因外伤后持续性腹部剧痛2小时来诊。查体：血压90/60mmHg，脉搏110次/分，子宫呈板状硬、压痛明显，胎心100次/分，阴道少量暗红色流血。最可能的诊断是

- A. 先兆早产
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早剥 ✅
- D. 子宫破裂

- E. 急性阑尾炎

答案：C

> 解析：胎盘早剥典型表现为妊娠20周后腹痛伴阴道流血，子宫张力增高、板状硬、压痛明显，可伴胎儿窘迫。本例有外伤诱因，持续性腹痛、子宫板状硬、胎心减慢、阴道少量暗红色流血，符合胎盘早剥（2级）。处理以纠正休克、及时终止妊娠为原则。教材P147。

---

133. [A2型题｜应用] batch034-M7-A2-006

> 模块：M7｜页码：教材P102

女，26岁。平素月经规律，现已妊娠41周+3日，无产兆。B超检查：羊水指数6.0cm，胎盘Ⅱ级，胎儿体重估计3200g，NST反应型。正确的处理是

- A. 继续等待自然临产
- B. 立即行剖宫产终止妊娠
- C. 住院引产终止妊娠 ✅
- D. 每日胎心监护即可
- E. 行羊膜腔穿刺评估胎儿成熟度

答案：C

> 解析：过期妊娠指妊娠达到或超过42周（≥294日）未分娩。妊娠41周后，胎盘功能减退、羊水减少、胎儿过熟综合征及巨大儿风险增加，妊娠41周+3日已超过41周，应住院引产终止妊娠，不宜继续等待。Bishop评分≥7分可直接引产，<7分先促宫颈成熟。教材P102。

---

134. [A3型题｜分析] batch034-M7-A3-001

> 模块：M7｜页码：教材P95

女，29岁。妊娠32周，血压160/105mmHg，尿蛋白（+++），近2日出现上腹疼痛、恶心呕吐。实验室检查：Hb 85g/L，血小板45×10^9/L，ALT 125U/L，LDH 800U/L，总胆红素45μmol/L。最可能的诊断是

- A. 妊娠期急性脂肪肝
- B. HELLP综合征 ✅
- C. 重度子痫前期

- D. 急性病毒性肝炎
- E. 急性胆囊炎

答案：B

> 解析：HELLP综合征是重度子痫前期的严重并发症，以溶血（H）、肝酶升高（EL）和血小板减少（LP）为特征。诊断标准：①溶血——血涂片见破碎红细胞、总胆红素≥20.5μmol/L、LDH≥600U/L；②肝酶升高（正常值2倍以上）；③血小板<100×10⁹/L。本例符合全部三条。与妊娠期急性脂肪肝鉴别：后者有低血糖、PT/APTT延长、血氨升高，而无高血压/蛋白尿。教材P95。

---

135. [A4型题｜应用] batch034-M7-A4-001

> 模块：M7｜页码：教材P93

女，31岁。妊娠34周，血压165/110mmHg，尿蛋白（+++），剧烈头痛、视力模糊。诊断重度子痫前期。入院后立即予硫酸镁静滴解痉、拉贝洛尔降压。经规范治疗24小时后血压仍波动在155～165/100～110mmHg，头痛未缓解，胎心监护NST无反应型。下一步最适宜的处理是

- A. 继续保守治疗至37周后终止妊娠
- B. 加用利尿剂减轻水肿
- C. 促胎肺成熟后期待至34周
- D. 积极治疗后尽快终止妊娠 ✅
- E. 转院继续保守治疗

答案：D

> 解析：重度子痫前期患者妊娠≥34周，经积极治疗24～48小时仍无明显好转（血压持续升高、症状未缓解、出现胎儿窘迫），应考虑终止妊娠。本例孕34周、血压控制不佳、头痛未缓解且胎儿窘迫（NST无反应型），应尽快终止妊娠以保障母儿安全。妊娠<34周者若病情稳定可促胎肺成熟后终止。教材P93。

---

136. [B1型题｜理解] batch034-M7-B1-001

> 模块：M7｜页码：教材P76

女，26岁。停经10周，阴道流血量增多伴下腹阵痛加剧，妇科检查宫颈口已扩张，可见妊娠组织堵塞宫口，子宫大小小于停经孕周。该患者的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产 ✅
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

答案：C

> 解析：不全流产指妊娠物部分排出体外，部分残留于宫腔内。妇科检查宫颈口扩张、有妊娠物堵塞、子宫小于停经孕周。因宫腔内残留妊娠物影响子宫收缩，血窦开放可致持续性大量出血，严重时可致失血性休克，应尽快行刮宫术或钳刮术。教材P76。

---

137. [B1型题｜理解] batch034-M7-B1-002

> 模块：M7｜页码：教材P77

女，32岁。连续自然流产3次，每次均发生在妊娠10～12周。查体无异常。实验室检查：ACA中高滴度阳性，狼疮抗凝物（LA）阳性。该患者复发性流产最可能的原因是

- A. 黄体功能不足
- B. 宫颈机能不全
- C. 抗磷脂综合征 ✅
- D. 胚胎染色体异常
- E. 甲状腺功能减退

答案：C

> 解析：抗磷脂综合征（APS）是导致复发性流产的重要免疫因素，诊断需至少一项临床标准（血栓形成、病态妊娠）加至少一项实验室标准（LA阳性、ACA中高滴度阳性、抗β2-GPⅠ抗体阳性）持续12周以上。APS相关流产多见于妊娠10周后，因胎盘血栓形成致胎盘功能不全。治疗采用低分子肝素联合阿司匹林。教材P77。［源:考研真题 GS-2023-056］

---

138. [X型题｜记忆] batch034-M7-X1-001

> 模块：M7｜页码：教材P81

输卵管妊娠破裂的典型临床表现包括

- A. 停经史明确 ✅
- B. 突发下腹撕裂样疼痛 ✅
- C. 肛门坠胀感 ✅
- D. 宫颈举痛阳性 ✅
- E. 阴道大量鲜红色流血

答案：ABCD

> 解析：输卵管妊娠破裂的典型临床表现为三联征：停经（6～8周）＋腹痛（95%为突发撕裂样疼痛）＋阴道流血（60%～80%为暗红色点滴状，量少）。内出血刺激直肠子宫陷凹可致肛门坠胀感；宫颈举痛为腹膜刺激征；出血多时子宫漂浮感。阴道流血量一般不多，系子宫蜕膜剥离所致，而非大量鲜红色出血。大量鲜红色阴道流血多见于前置胎盘或不全流产。教材P81。

---

139. [X型题｜理解] batch034-M7-X2-001

> 模块：M7｜页码：教材P88

子痫前期-子痫的病理生理改变包括

- A. 全身小血管痉挛 ✅
- B. 血管内皮损伤 ✅
- C. 螺旋动脉重塑不足 ✅
- D. 胎盘缺血缺氧 ✅
- E. 全身血容量明显增加

答案：ABCD

> 解析：子痫前期-子痫的基本病理生理为全身小血管痉挛和血管内皮损伤。发病机制两阶段：第一阶段为胎盘浅着床、螺旋动脉重塑不足（仅蜕膜层血管重塑，管腔径仅正常1/2），导致胎盘灌注不足、缺血缺氧；第二阶段为胎盘因子释放入母体循环，激活炎症反应和内皮损伤，引起全身小血管痉挛、各脏器灌注减少。妊娠期血容量增加是正常妊娠生理变化，而非子痫前期的病理改变。教材P88。

M8（5题）

140. [A1型题｜记忆] batch034-M8-A1-001

> 模块：M8｜页码：教材P105

妊娠合并心脏病的孕妇，最易发生心力衰竭的时期是

- A. 妊娠20～24周
- B. 妊娠28～30周
- C. 妊娠32～34周 ✅
- D. 妊娠36～38周
- E. 妊娠40周后

答案：C

> 解析：妊娠合并心脏病孕妇最易发生心衰的三个危险时期为：妊娠32～34周（血容量和心输出量达高峰）、分娩期（每次宫缩250～500ml血液进入体循环）、产后3日内（尤其产后24小时，组织间潴留液回体循环）。妊娠32～34周是孕期血容量负荷峰值期，心脏代偿能力不足易诱发心衰。教材P105。

---

141. [A1型题｜理解] batch034-M8-A1-005

> 模块：M8｜页码：教材P108

妊娠合并心脏病，心功能NYHA分级Ⅲ级的孕妇，分娩方式应选择

- A. 阴道分娩，产钳助产
- B. 行择期剖宫产 ✅
- C. 阴道分娩，缩短第二产程
- D. 阴道分娩，硬膜外镇痛
- E. 期待至自然分娩

答案：B

> 解析：心功能NYHA分级Ⅲ级（活动明显受限，休息时无症状）和Ⅳ级（休息时也有症状）的妊娠合并心脏病孕妇，均应择期剖宫产。Ⅰ～Ⅱ级且无其他高危因素者可考虑阴道试产，但需缩短第二产程、避免屏气用力。分娩期禁用麦角新碱（增加心脏负荷），可用缩宫素。教材P108。

---

142. [A2型题｜应用] batch034-M8-A2-002

> 模块：M8｜页码：教材P105

女，28岁。妊娠33周，风湿性心脏病二尖瓣狭窄史。近2日轻微活动后感胸闷、心悸、气短。查体：心率115次/分，呼吸22次/分，双肺底闻及少量湿啰音，咳嗽后不消失。该患者最可能的诊断是

- A. 正常妊娠生理反应
- B. 早期心力衰竭 ✅
- C. 肺部感染
- D. 支气管哮喘
- E. 妊娠期高血压疾病

答案：B

> 解析：妊娠合并心脏病早期心力衰竭的征象包括：①轻微活动后胸闷、心悸、气短；②休息时心率>110次/分、呼吸>20次/分；③夜间胸闷须坐起呼吸；④肺底部持续湿啰音、咳嗽后不消失。本例孕33周（血容量高峰期）、心率115次/分、肺底湿啰音不消失，符合早期心衰表现。妊娠32～34周是心衰高发期，应警惕。教材P105。

---

143. [A4型题｜应用] batch034-M8-A4-001

> 模块：M8｜页码：教材P110

女，28岁。妊娠38周，风湿性心脏病二尖瓣狭窄（NYHAⅡ级），无产科并发症，胎位LOA，胎儿体重估计3200g。临产后规律宫缩，宫口开大3cm，胎心正常。产程中应特别注意的环节是

- A. 第一产程鼓励孕妇屏气用力以缩短产程
- B. 第二产程避免产妇屏气用力，必要时产钳助产 ✅
- C. 胎儿娩出后立即静注麦角新碱预防产后出血

- D. 产后大量输液补充血容量
- E. 产后立即下床活动预防血栓

答案：B

> 解析：妊娠合并心脏病（NYHAⅡ级）可阴道试产，但需注意：第一产程镇静、镇痛、避免血压波动；第二产程避免产妇屏气用力（增加肺循环压力和心脏负荷，易诱发心衰），可予以产钳或胎头吸引器助产缩短第二产程。胎儿娩出后禁用麦角新碱（增加心脏后负荷），可用缩宫素预防产后出血。产后3日内尤其产后24小时是心衰高发期，应限制液体入量、监测心功能、充分休息。教材P110。

---

144. [X型题｜理解] batch034-M8-X1-001

> 模块：M8｜页码：教材P108

妊娠合并心脏病孕妇的处理原则，正确的有

- A. 妊娠32～34周应加强监护，预防心衰 ✅
- B. 分娩期可选用硬膜外镇痛减轻心脏负担 ✅
- C. 第二产程可产钳助产缩短产程 ✅
- D. 产后24小时内应严格限制液体入量 ✅
- E. 产后出血应首选麦角新碱止血

答案：ABCD

> 解析：妊娠合并心脏病孕妇的处理：①妊娠期——32～34周血容量高峰，应加强监护、预防心衰；②分娩期——硬膜外镇痛可减轻心脏负荷，第二产程避免屏气用力，必要时产钳助产缩短产程；③产褥期——产后3日内（尤其24小时）是心衰高发期，应限制液体入量、监测心功能、充分休息；④产后出血禁用麦角新碱（增加心脏负荷），首选缩宫素。教材P108。

M9（19题）

145. [A1型题｜记忆] batch034-M9-A1-001

> 模块：M9｜页码：教材P208

产褥期是指

- A. 从胎儿娩出至生殖器官恢复的时期
- B. 从胎盘娩出至除乳腺外器官恢复至未孕状态 ✅
- C. 从临产至产后42日的时期
- D. 从胎盘娩出至恶露干净的时期
- E. 产后6个月内任一时期

答案：B

> 解析：从胎盘娩出至产妇全身各器官（除乳腺外）恢复至正常未孕状态所需的一段时期称为产褥期，通常为6周。教材P208。

---

146. [A1型题 | 理解] batch034-M9-A1-002

> 模块：M9 | 页码：教材P208

关于子宫复旧的主要变化，错误的是

- A. 宫体肌纤维缩复是肌细胞质减少、细胞缩小
- B. 宫体肌纤维缩复是肌细胞数目减少 ✅
- C. 子宫内膜基底层再生新的功能层
- D. 胎盘附着部位内膜修复需至产后6周
- E. 开放的子宫螺旋动脉和静脉窦内形成血栓

答案：B

> 解析：子宫复旧不是肌细胞数目减少，而是肌细胞质中的蛋白质被分解排出，使细胞质减少致肌细胞缩小；子宫内膜基底层逐渐再生新的功能层，约产后第3周除胎盘附着部位外均被新生内膜覆盖，胎盘附着部位修复需至产后6周。教材P208。

---

147. [A1型题 | 记忆] batch034-M9-A1-003

> 模块：M9 | 页码：教材P208

分娩结束时子宫重量约为

- A. 500g
- B. 800g

- C. 1000g ✅
- D. 1500g
- E. 2000g

答案：C

> 解析：分娩结束时子宫约为1000g，产后1周约为500g，产后2周约为300g，产后6周恢复至50～70g。教材P208。

---

148. [A1型题｜理解] batch034-M9-A1-004

> 模块：M9｜页码：教材P210

血性恶露转变为浆液恶露发生在产后

- A. 第1～2日
- B. 第3～4日 ✅
- C. 第7～8日
- D. 第2周末
- E. 第3周末

答案：B

> 解析：血性恶露鲜红、量多、有时有小血块，持续3～4日后出血逐渐减少、浆液增加，转变为淡红色的浆液恶露；浆液恶露持续10日左右转为白色恶露，白色恶露约持续3周干净。恶露总量250～500ml，持续4～6周。教材P210。

---

149. [A1型题｜记忆] batch034-M9-A1-005

> 模块：M9｜页码：教材P213

产褥发热是指分娩24小时以后的10日内，每日间隔4小时测量体温，有2次体温达到或超过

- A. 37.3℃
- B. 37.8℃
- C. 38.0℃ ✅
- D. 38.5℃

- E. 39.0℃

答案：C

> 解析：产褥发热指分娩24小时以后的10日内，每日间隔4小时测量体温，有2次体温达到或超过38℃。产褥发热常由产褥感染引起，也可由急性乳腺炎、上呼吸道感染、泌尿系统感染、血栓静脉炎等所致。教材P213。

---

150. [A1型题 | 记忆] batch034-M9-A1-006

> 模块：M9 | 页码：教材P213

产褥感染的三大主要症状是

- A. 发热、腹痛、腹泻
- B. 发热、疼痛、异常恶露 ✅
- C. 高热、寒战、黄疸
- D. 发热、阴道流血、尿频
- E. 发热、乳房胀痛、下肢水肿

答案：B

> 解析：发热、疼痛、异常恶露为产褥感染三大主要症状。产褥发热者首先考虑产褥感染，再排除引起产褥发热的其他疾病。教材P213。

---

151. [A1型题 | 理解] batch034-M9-A1-007

> 模块：M9 | 页码：教材P215

阴道分娩后晚期产后出血最常见的原因是

- A. 子宫胎盘附着面复旧不全
- B. 胎盘、胎膜残留 ✅
- C. 蜕膜组织残留
- D. 子宫内膜炎感染
- E. 子宫动静脉畸形

答案：B

> 解析：胎盘、胎膜残留为阴道分娩后晚期产后出血最常见的原因，多发生于产后10日左右；胎盘附着面复旧不全多发生在产后2周左右；剖宫产子宫切口裂开或愈合不良所致出血多在术后2～3周发生。教材P215。

---

152. [A2型题｜理解] batch034-M9-A2-001

> 模块：M9｜页码：教材P210

关于产后宫缩痛，正确的是

- A. 多见于初产妇人群
- B. 哺乳时缩宫素增多致疼痛加重 ✅
- C. 需常规给予强效镇痛药
- D. 提示存在宫腔感染
- E. 多发生在产后2周

答案：B

> 解析：产后宫缩痛是产褥早期因子宫收缩引起的下腹部阵发性剧烈疼痛，多见于经产妇，哺乳时反射性缩宫素分泌增多使疼痛加重，不需要特殊用药。教材P210。

---

153. [A2型题｜理解] batch034-M9-A2-002

> 模块：M9｜页码：教材P210

关于泌乳热，错误的是

- A. 多发生在产后3～4日
- B. 与乳房血管、淋巴管极度充盈有关
- C. 一般持续4～16小时体温即下降
- D. 需排除感染引起的发热
- E. 体温常超过39℃且持续不退 ✅

答案：E

> 解析：产后3～4日乳房血管、淋巴管极度充盈，乳房胀大，伴体温升高，称为泌乳热，一般持续4～16小时体温即下降，但需排除其他原因尤其是感染引起的发热；体温不会持续超过39℃不退。教材P210。

---

154. [A2型题 | 应用] batch034-M9-A2-003

> 模块：M9 | 页码：教材P210

初产妇，产后1小时回病房。阴道流血量不多，但子宫收缩不良、宫底上升。最可能的原因是

- A. 宫腔内积血 ✅
- B. 膀胱充盈致子宫移位
- C. 子宫破裂出血
- D. 急性羊水栓塞
- E. 凝血功能障碍

答案：A

> 解析：产后2小时内极易发生产后出血等严重并发症。若阴道流血量不多但子宫收缩不良、宫底上升，提示宫腔内可能有积血，应压宫底排出积血，并持续给予子宫收缩剂。教材P210。

---

155. [A2型题 | 应用] batch034-M9-A2-004

> 模块：M9 | 页码：教材P216

女，28岁。阴道分娩后12日，突然大量阴道流血伴血凝块，血压90/60mmHg，超声示宫腔内残留组织回声。下列处理不恰当的是

- A. 静脉输液、备血准备
- B. 在具备手术条件下行清宫术
- C. 刮出物送病理检查
- D. 术后给予抗菌药物及子宫收缩剂
- E. 立即在无输血抢救条件下急诊清宫 ✅

答案：E

> 解析：疑有胎盘、胎膜、蜕膜残留者，应在静脉输液、备血及准备手术的条件下行清宫术，操作轻柔以防子宫穿孔，刮出物送病理；术后继续给予抗菌药物及子宫收缩剂。在无输液备血和手术保障的情况下直接清宫易致大出血和子宫穿孔，不恰当。教材P216。

---

156. [A2型题 | 应用] batch034-M9-A2-005

> 模块：M9 | 页码：教材P217

女，30岁。剖宫产术后22日，突然大量阴道流血，超声提示子宫下段切口处假性动脉瘤形成。首选治疗是

- A. 行清宫术清除残留
- B. 髂内动脉或子宫动脉栓塞术 ✅
- C. 等待观察子宫动脉瘤变化
- D. 大量雌激素止血
- E. 阴道填塞压迫止血

答案：B

> 解析：剖宫产子宫切口愈合不良所致晚期产后出血多在术后2～3周发生，常为突然大量出血；若为切口假性动脉瘤形成，首选髂内动脉或选择性子宫动脉栓塞术；组织坏死范围大者酌情行子宫切除术。清宫术禁用于切口裂开者，易致子宫破裂。教材P217。

---

157. [A2型题 | 应用] batch034-M9-A2-006

> 模块：M9 | 页码：教材P212

产妇因婴儿患有乳糖不耐受症不能哺乳，要求退奶。可采用的退奶方法是

- A. 生麦芽水煎当茶饮 ✅
- B. 溴隐亭常规使用
- C. 甾体激素大剂量使用
- D. 继续哺乳并加吸乳器
- E. 热敷乳房并按摩

答案：A

> 解析：最简单的退奶方法是停止哺乳，必要时辅以药物：生麦芽60～90g水煎当茶饮每日1剂连服3～5日；芒硝250g分装两纱布袋敷于两乳房并包扎；维生素B6 200mg每日3次。甾体激素、溴隐亭等不推荐作为一线退奶药物。教材P212。

---

158. [A3型题｜分析] batch034-M9-A3-001

> 模块：M9｜页码：教材P214

女，29岁。阴道分娩后4日出现寒战、高热，体温39.2℃，下腹压痛。恶露量增多呈脓性、有臭味，子宫复旧不全、压痛明显，白细胞15×10^9/L。最可能的诊断是

- A. 急性子宫内膜炎、子宫肌炎 ✅
- B. 急性上呼吸道感染
- C. 急性乳腺炎表现
- D. 泌尿系统感染
- E. 产后子宫收缩痛

答案：A

> 解析：病原体经胎盘剥离面侵入，扩散至子宫蜕膜层称子宫内膜炎，侵入子宫肌层称子宫肌炎，两者常伴发；表现为恶露增多呈脓性且有臭味、腹痛、子宫压痛明显、子宫复旧不全，伴高热寒战等全身症状。本例产后4日、脓性臭味恶露、子宫压痛与复旧不全，符合产褥感染之子宫感染。教材P214。

---

159. [A4型题｜应用] batch034-M9-A4-001

> 模块：M9｜页码：教材P214

女，31岁。产后10日出现寒战、高热交替，左下肢持续性疼痛、水肿，皮肤发白，局部静脉压痛并可触及硬索状结构，彩色多普勒超声示左股静脉血栓。在应用大量抗菌药物的同时，可加用的治疗是

- A. 肝素钠抗凝治疗 ✅
- B. 立即手术取栓
- C. 大剂量雌激素
- D. 患肢热敷按摩
- E. 仅口服抗生素观察

答案：A

> 解析：下肢血栓性静脉炎常继发于盆腔静脉炎，多发生在股静脉、腘静脉及大隐静脉，表现为弛张热、下肢持续性疼痛、水肿、皮肤发白（俗称股白肿）。治疗时在应用大量抗菌药物的同时，可加用肝素钠150U/（kg·d）加入5%葡萄糖注射液500ml静脉滴注，每6小时1次，用药期间监测凝血功能。禁止患肢热敷按摩以防血栓脱落。教材P214。

---

160. [B1型题｜记忆] batch034-M9-B1-001

> 模块：M9｜页码：教材P210

产后2日，恶露鲜红色、量多、有时有小血块，镜下见多量红细胞、坏死蜕膜及少量胎膜。该恶露类型是

- A. 血性恶露 ✅
- B. 浆液恶露
- C. 白色恶露
- D. 羊水
- E. 月经

答案：A

> 解析：血性恶露因含大量血液得名，鲜红色、量多、有时有小血块，持续3～4日。教材P210。

---

161. [B1型题｜记忆] batch034-M9-B1-002

> 模块：M9｜页码：教材P210

产后7日，恶露淡红色，含较多坏死蜕膜组织、宫腔渗出液、宫颈黏液及少量红细胞。该恶露类型是

- A. 血性恶露
- B. 浆液恶露 ✅
- C. 白色恶露
- D. 羊水
- E. 月经

答案：B

> 解析：浆液恶露因含多量浆液得名，淡红色，持续10日左右，多见于产后4日至2周内。教材P210。

---

162. [X型题｜理解] batch034-M9-X1-001

> 模块：M9｜页码：教材P209

正常产褥期母体变化中，正确的有

- A. 产后72小时循环血量增15%～25% ✅
- B. 产褥早期血液仍处于高凝状态 ✅
- C. 产后1周内尿量增多 ✅
- D. 白细胞产褥早期15～30×10^9/L ✅
- E. 血hCG于产后6小时已不能测出

答案：ABCD

> 解析：产后72小时内产妇循环血量增加15%～25%，应注意预防心力衰竭；产褥早期血液高凝有利于胎盘剥离创面止血，但也是深静脉血栓的危险因素；产后1周内尿量增多；白细胞总数产褥早期可达（15～30）×10^9/L，1～2周恢复。产后6小时不能测出的是人胎盘催乳素，血hCG通常于产后10日左右恢复至非妊娠水平。教材P209。

---

163. [X型题｜理解] batch034-M9-X2-001

> 模块：M9｜页码：教材P211

关于母乳喂养，正确的有

- A. 帮助母亲在产后1小时内开始母乳喂养 ✅
- B. 坚持纯母乳喂养6个月 ✅
- C. 母乳20～30℃保存不超过4小时 ✅
- D. 婴儿每日排尿5～6次提示乳汁分泌量充足 ✅
- E. 哺乳期月经未复潮者不可能受孕

答案：ABCD

> 解析：WHO已将产后1小时内开始哺乳、24小时母婴同室、纯母乳喂养6个月、提倡母乳喂养2年以上纳入促进母乳喂养成功措施；乳汁储存20～30℃不超过4小时、4℃不超过48小时、-15～-5℃可保存6个月；判断乳汁充足标准包括每日满意哺乳8次左右、婴儿每日排尿5～6次及体重增长良好。产后较晚月经复潮者首次月经来潮前多有排卵，哺乳产妇月经未复潮仍有受孕可能。教材P211。

M10（18题）

164. [A1型题｜理解] batch034-M10-A1-001

> 模块：M10丨页码：教材P233

正常阴道微生态中起核心保护作用的优势菌是

- A. 加德纳菌属
- B. 葡萄球菌属
- C. 产过氧化氢的乳杆菌 ✅
- D. 大肠埃希菌
- E. 消化链球菌

答案：C

> 解析：正常阴道微生态以产过氧化氢（H2O2）的乳杆菌为优势菌，乳杆菌可维持阴道酸性环境（pH≤4.5），分泌H2O2、细菌素等抑制致病微生物，并通过竞争排斥阻止致病菌黏附。教材P233。

---

165. [A1型题｜记忆] batch034-M10-A1-002

> 模块：M10丨页码：教材P235

外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）最常见的病原体是

- A. 热带假丝酵母菌
- B. 光滑假丝酵母菌
- C. 白假丝酵母菌 ✅
- D. 近平滑假丝酵母菌

- E. 克柔假丝酵母菌

答案：C

> 解析：80%～90%的VVC病原体为白假丝酵母菌，10%～20%为非白假丝酵母菌（光滑假丝酵母菌、近平滑假丝酵母菌、热带假丝酵母菌等）。教材P235。

---

166. [A1型题｜理解] batch034-M10-A1-004

> 模块：M10丨页码：教材P249

非妊娠期、非产褥期盆腔炎性疾病的主要感染途径是

- A. 经血液循环传播
- B. 沿生殖道黏膜上行蔓延 ✅
- C. 经淋巴系统蔓延
- D. 局部直接蔓延
- E. 经性交直接传播

答案：B

> 解析：沿生殖道黏膜上行蔓延是非妊娠期、非产褥期PID的主要感染途径，病原体沿子宫颈黏膜、子宫内膜、输卵管黏膜蔓延至卵巢及腹腔。经淋巴系统蔓延是产褥感染、流产后感染及IUD后感染的主要途径。教材P249。

---

167. [A1型题｜理解] batch034-M10-A1-005

> 模块：M10丨页码：教材P254

关于盆腔炎性疾病后遗症的描述，错误的是

- A. 后遗症不孕率约20%～30%
- B. 异位妊娠发生率是正常女性的8～10倍
- C. 慢性盆腔痛约20%
- D. 反复发作率约25%
- E. 后遗症主要源于粘连瘢痕而非病原体损伤 ✅

答案：E

> 解析：PID后遗症的主要病理改变为组织破坏、广泛粘连、增生及瘢痕形成，导致不孕（20%～30%）、异位妊娠（8～10倍）、慢性盆腔痛（约20%）、反复发作（约25%）。后遗症的核心机制是粘连瘢痕而非单纯病原体损伤。教材P254。

---

168. [A1型题 | 记忆] batch034-M10-A1-006

> 模块：M10 | 页码：教材P269

子宫内膜异位症最常累及的器官是

- A. 子宫骶韧带
- B. 双侧卵巢 ✅
- C. 直肠子宫陷凹
- D. 输卵管
- E. 膀胱壁

答案：B

> 解析：内异症可侵袭全身任何部位，以卵巢最常见（约占80%单侧、50%双侧），其次为子宫骶韧带、直肠子宫陷凹等。卵巢异位内膜易形成巧克力囊肿。教材P269。

---

169. [A1型题 | 记忆] batch034-M10-A1-007

> 模块：M10 | 页码：教材P277

目前对于子宫腺肌病尚无根治效果的药物，缓解症状可选择的药物不包括****

- A. 非甾体抗炎药
- B. 左炔诺孕酮宫内释放系统
- C. GnRH-a
- D. 口服短效避孕药
- E. 米非司酮治疗 ✅

答案：E

> 解析：子宫腺肌病目前无根治性药物。NSAID、LNG-IUS、GnRH-a、口服避孕药等可缓解症状，但停药后症状复现。米非司酮可缩小病灶但并非根治性治疗，且不宜长期使用。症状严重无生育要求者行全子宫切除术。教材P277。

---

170. [A1型题 | 记忆] batch034-M10-A1-008

> 模块：M10 | 页码：教材P235

前庭大腺脓肿形成后首选的处理方法是

- A. 口服抗菌药物观察
- B. 局部热敷
- C. 尽早切开引流 ✅
- D. 穿刺抽脓
- E. 乙醇注射硬化治疗

答案：C

> 解析：前庭大腺脓肿形成后需尽早切开引流，缓解疼痛、控制炎症，切口应选择在波动感明显处并放置引流条，脓液送细菌培养。单纯抗菌药物治疗无法解决已形成的脓肿。教材P235。

---

171. [A2型题 | 应用] batch034-M10-A2-002

> 模块：M10 | 页码：教材P235

女，28岁。糖尿病史2年，近3日外阴瘙痒剧烈，阴道分泌物呈白色豆腐渣样。妇科检查见外阴红肿，阴道黏膜附有白色块状物，擦除后黏膜充血。阴道pH 4.0。最可能的诊断是

- A. 细菌性阴道病
- B. 需氧菌性外阴阴道炎
- C. 阴道毛滴虫病
- D. 外阴阴道假丝酵母菌病 ✅
- E. 萎缩性阴道炎

答案：D

> 解析：糖尿病是VVC的常见诱因。白色豆腐渣样分泌物、重度外阴瘙痒、阴道pH＜4.5（VVC是唯一pH＜4.5的阴道炎），均符合外阴阴道假丝酵母菌病。治疗首选唑类抗真菌药物局部或全身应用。教材P235。

---

172. [A2型题｜应用] batch034-M10-A2-003

> 模块：M10丨页码：教材P251

女，26岁。性活跃，反复下腹痛3日，伴阴道分泌物增多。妇科检查：子宫颈举痛，子宫体压痛，双侧附件区压痛。阴道分泌物生理盐水湿片见大量白细胞。最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 卵巢囊肿蒂扭转
- C. 异位妊娠破裂
- D. 盆腔炎性疾病 ✅
- E. 子宫内膜异位症

答案：D

> 解析：性活跃年轻女性，下腹痛＋子宫颈举痛/子宫压痛/附件区压痛（最低标准），符合2021 CDC推荐的PID诊断最低标准，可给予抗菌药物治疗。阴道分泌物大量白细胞为附加标准，增加特异性。教材P251。

---

173. [A2型题｜理解] batch034-M10-A2-004

> 模块：M10丨页码：教材P241

女，30岁。阴道分泌物增多呈黄绿色泡沫状，外阴瘙痒。阴道黏膜散在出血点，分泌物找到阴道毛滴虫。关于治疗措施，错误的是

- A. 甲硝唑0.4g口服每日2次×7日
- B. 性伴侣需同时治疗
- C. 治疗期间禁忌饮酒
- D. 单纯局部用药即可根治 ✅
- E. 治愈前避免无保护性行为

答案：D

> 解析：阴道毛滴虫病为外源性病原体，常侵及尿道、尿道旁腺、前庭大腺等部位，需全身用药（甲硝唑口服），且性伴侣需同时治疗，仅局部用药无法根治。用药期间禁酒，治愈前避免无保护性行为。教材P241。

---

174. [A2型题 | 应用] batch034-M10-A2-005

> 模块：M10 | 页码：教材P271

女性，41岁。腹胀、低热3个月。既往有右侧附件结核病史2年。查体：T 37.8℃，腹壁柔韧感，轻压痛，移动性浊音阳性。对确定诊断最有价值的检查是

- A. 腹部B超
- B. 腹部CT
- C. 腹水检查 ✅
- D. 妇科双合诊检查
- E. 结核菌素试验

答案：C

> 解析：[源:考研真题 GS-2021-051] 结核性腹膜炎常继发于腹腔内结核（如附件结核），表现为低热、腹壁柔韧感、腹水；对确定诊断最有价值的检查是腹水检查（腹水找结核分枝杆菌、ADA 测定）。

---

175. [A2型题 | 理解] batch034-M10-A2-006

> 模块：M10 | 页码：教材P244

女，24岁。阴道分泌物增多3日，伴性交后出血。妇科检查见子宫颈口大量黏液脓性分泌物，拭子擦拭子宫颈管口易出血。子宫颈管分泌物中性粒细胞＞30个/HPF。最可能的诊断是

- A. 慢性子宫颈炎
- B. 急性子宫颈炎 ✅
- C. 子宫颈息肉
- D. 子宫颈上皮内病变
- E. 子宫颈癌

答案：B

> 解析：黏液脓性分泌物（MPC）＋子宫颈管口易出血（脆性增加）＋宫颈管分泌物中性粒细胞＞30个/HPF，符合急性子宫颈炎的诊断标准。病原体多为淋病奈瑟球菌或沙眼衣原体，需行病原体检测。教材P244。［源:考研真题 GS-2023-039］

---

176. [A3型题｜分析] batch034-M10-A3-001

> 模块：M10｜页码：教材P318

女，28岁。妊娠33周，突发下腹剧痛伴恶心、呕吐、发热1小时。查体：T 38.5℃，下腹部压痛，子宫右前壁局部压痛明显。超声示子宫右前壁一8cm×7cm低回声区，局部压痛，该区域血流信号减少。最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 肌瘤红色变性 ✅
- C. 急性阑尾炎
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 先兆早产

答案：B

> 解析：妊娠期子宫肌瘤红色变性表现为突发剧烈腹痛伴恶心、呕吐、发热，肌瘤局部压痛明显，超声可见肌瘤内血流减少。妊娠期及产褥期肌瘤易发生红色变性，机制为肌瘤内小血管退行性变引起血栓及溶血，血红蛋白渗入肌纤维间。通常保守治疗可缓解。教材P318。

---

177. [A4型题｜应用] batch034-M10-A4-001

> 模块：M10｜页码：教材P253

女，34岁。下腹痛伴发热3日，T 39.1℃。妇科检查：子宫颈举痛，子宫体压痛明显，双侧附件区增厚压痛。超声示右侧附件区6cm×5cm囊性包块，壁厚，内见分隔。血WBC 15.2×10^9/L，N 0.85。经头孢曲松+多西环素+甲硝唑静脉治疗48小时，体温仍持续38.5℃以上，包块增大至7cm×6cm。下一步最适宜的处理是

- A. 继续观察患侧附件包块3日
- B. 更换为喹诺酮类药物
- C. 行手术治疗（脓肿引流或患侧附件切除） ✅
- D. 加用糖皮质激素抗炎

- E. 仅行附件区穿刺抽脓

答案：C

> 解析：PID患者经药物治疗48～72小时体温不降、包块增大，提示药物治疗无效，应及时手术（腹腔镜或开腹）行脓肿切开引流或患侧附件切除术，以免脓肿破裂。术前应继续抗菌药物治疗。教材P253。

---

178. [B1型题｜理解] batch034-M10-B1-001

> 模块：M10｜页码：教材P246

子宫颈管腺体和间质的局限性增生，向子宫颈外口突出形成舌形赘生物，质软而脆，极少恶变。该病理类型是

- A. 慢性子宫颈管黏膜炎
- B. 子宫颈息肉 ✅
- C. 子宫颈肥大
- D. 子宫颈腺囊肿
- E. 生理性柱状上皮异位

答案：B

> 解析：子宫颈息肉是子宫颈管腺体和间质的局限性增生，向子宫颈外口突出形成息肉，表面被覆高柱状上皮，间质水肿、血管丰富及慢性炎细胞浸润，极少恶变。应与子宫恶性肿瘤鉴别。教材P246。［源:考研真题 GS-2023-039］

---

179. [B1型题｜理解] batch034-M10-B1-002

> 模块：M10｜页码：教材P246

慢性炎症长期刺激导致腺体及间质增生，子宫颈不同程度增大、硬度增加，但一般无须治疗。该病理类型是

- A. 慢性子宫颈管黏膜炎
- B. 子宫颈息肉
- C. 子宫颈肥大 ✅
- D. 子宫颈腺囊肿

- E. 生理性柱状上皮异位

答案：C

> 解析：子宫颈肥大由慢性炎症长期刺激导致腺体及间质增生，子宫颈深部的腺囊肿也可使子宫颈肥大。一般无须治疗，但需与子宫颈腺癌鉴别。教材P246。

---

180. [X型题｜记忆] batch034-M10-X1-001

> 模块：M10｜页码：教材P270

子宫内膜异位症发病的相关学说包括

- A. Sampson种植学说 ✅
- B. 体腔上皮化生学说 ✅
- C. 诱导学说观点 ✅
- D. 遗传与免疫炎症因素 ✅
- E. 淋巴及静脉播散学说

答案：ABCD

> 解析：内异症发病学说主要包括：Sampson种植学说（经血逆流、淋巴及静脉播散、医源性种植）、体腔上皮化生学说、诱导学说、遗传因素（一级亲属风险7倍）、免疫与炎症因素。E选项'单纯血行感染'不能概括淋巴及静脉播散的完整机制。教材P270。

---

181. [X型题｜理解] batch034-M10-X2-001

> 模块：M10｜页码：教材P276

子宫腺肌病的临床特征包括

- A. 子宫均匀增大、质硬 ✅
- B. 经量过多、经期延长 ✅
- C. 继发性进行性痛经，经期压痛更甚 ✅
- D. 对孕激素治疗反应良好
- E. 常合并子宫肌瘤或内异症 ✅

答案：ABCE

> 解析：子宫腺肌病主要表现为经量过多（40%～50%）、经期延长和进行性继发性痛经，子宫均匀增大质硬（球形，一般不超过12孕周），经期压痛更甚。约15%合并内异症、约半数合并子宫肌瘤。但腺肌病异位内膜属基底层不成熟内膜，对孕激素无反应（此点与内异症不同）。教材P276。

M11（20题）

182. [A1型题｜理解] batch034-M11-A1-001

> 模块：M11｜页码：教材P311

子宫颈癌FIGO 2018分期中，ⅠA1期是指间质浸润深度

- A. 浸润≤1mm
- B. 浸润≤3mm ✅
- C. 浸润≤5mm
- D. ＞3mm且≤5mm
- E. ＞5mm但≤7mm

答案：B

> 解析：FIGO 2018分期中，ⅠA期为镜下浸润癌，间质浸润深度≤5mm。ⅠA1浸润深度≤3mm，ⅠA2浸润深度＞3mm且≤5mm。ⅠB期为浸润深度＞5mm或临床可见病灶局限于宫颈。教材P311。［源:考研真题 GS-2019-039］

---

183. [A1型题｜记忆] batch034-M11-A1-002

> 模块：M11｜页码：教材P304

高危型HPV感染导致子宫颈癌的关键机制是病毒癌蛋白

- A. E2和E4降解p53
- B. E5和E6增强Rb功能
- C. E6降解p53、E7失活Rb ✅
- D. E1和E2激活细胞周期
- E. L1和L2诱导免疫逃逸

答案：C

> 解析：高危型HPV（如HPV16、18）的癌蛋白E6与野生型p53结合使其降解灭活，E7与Rb基因产物结合使其失活，两条抑癌通路同时被废除，导致细胞周期失控、基因组不稳定，最终发生上皮内病变及癌变。教材P304。［源:考研真题 GS-2022-037］

---

184. [A1型题｜理解] batch034-M11-A1-003

> 模块：M11｜页码：教材P317

子宫肌瘤最常见的临床症状是

- A. 下腹部包块
- B. 经量增多及经期延长 ✅
- C. 阴道分泌物增多
- D. 压迫症状（尿频便秘）
- E. 不孕症表现

答案：B

> 解析：经量增多及经期延长是子宫肌瘤最常见的症状，多见于体积较大的肌壁间肌瘤及黏膜下肌瘤。肌瘤使子宫增大、子宫内膜面积增加并影响子宫收缩，导致经量增多、经期延长。长期可继发贫血。教材P317。

---

185. [A1型题｜理解] batch034-M11-A1-004

> 模块：M11｜页码：教材P316

按肌瘤与子宫壁肌层的关系分类，最常见的类型是

- A. 浆膜下肌瘤
- B. 黏膜下肌瘤
- C. 肌壁间肌瘤 ✅
- D. 子宫颈肌瘤
- E. 阔韧带肌瘤

答案：C

> 解析：按肌瘤与子宫肌壁的关系分为3类：肌壁间肌瘤占60%～70%（最常见），浆膜下肌瘤约占20%，黏膜下肌瘤占10%～15%。子宫颈肌瘤仅占约10%。教材P316。

---

186. [A1型题｜理解] batch034-M11-A1-005

> 模块：M11｜页码：教材P326

子宫内膜癌最典型的临床表现是

- A. 接触性出血
- B. 绝经后阴道流血 ✅
- C. 下腹部包块
- D. 大量米泔样恶臭排液
- E. 腹痛伴发热

答案：B

> 解析：约90%的子宫内膜癌患者出现阴道流血或分泌物增多，绝经后阴道流血为最典型表现。未绝经者可表现为经量增多、经期延长或经间期出血。接触性出血更常见于宫颈癌。教材P326。

---

187. [A1型题｜记忆] batch034-M11-A1-006

> 模块：M11｜页码：教材P326

诊断子宫内膜癌最可靠的检查方法是

- A. 盆腔超声检查
- B. MRI检查
- C. 血清CA125测定
- D. 分段诊刮病理检查 ✅
- E. 宫腔镜检查

答案：D

> 解析：子宫内膜癌确诊依据是活组织病理检查，最常用诊断性刮宫（分段诊刮可同时取宫腔和宫颈组织，鉴别宫颈受累），是诊断的金标准。超声、MRI为辅助检查。教材P326。

188. [A1型题｜理解] batch034-M11-A1-007

> 模块：M11丨页码：教材P320

下列不属于子宫肌瘤手术适应证的是

- A. 月经过多致继发性贫血
- B. 肌瘤体积过大引起压迫症状
- C. 影响妊娠及生育
- D. 无症状直径＜5cm肌壁间肌瘤 ✅
- E. 可疑肌瘤恶变可能

答案：D

> 解析：子宫肌瘤手术适应证包括：月经过多致继发性贫血、肌瘤体积过大、有疼痛或压迫症状、影响妊娠、可疑肌瘤恶变。无症状肌瘤一般不需治疗，每3～6个月随访即可，绝经后多可萎缩。教材P320。

---

189. [A1型题｜记忆] batch034-M11-A1-008

> 模块：M11丨页码：教材P317

子宫肌瘤最常见的变性类型是

- A. 玻璃样变性 ✅
- B. 囊性变
- C. 红色变性
- D. 钙化变性
- E. 肉瘤变

答案：A

> 解析：子宫肌瘤玻璃样变性（透明变性）最为常见，肌瘤剖面旋涡状结构消失，由均匀透明样物质取代。镜下见病变区肌细胞消失，为粉红色均匀透明无结构的胶原纤维。教材P317。

---

190. [A2型题｜应用] batch034-M11-A2-001

> 模块：M11｜页码：教材P307

女，42岁，G2P1，既往体健。首次来妇科就诊要求宫颈癌筛查。根据我国筛查方案，最适合的初筛方法是

- A. HPV核酸检测 ✅
- B. 子宫颈细胞学检查（巴氏涂片）
- C. 肉眼筛查（醋酸试验）
- D. 阴道镜检查定位
- E. HPV疫苗立即接种后再筛查

答案：A

> 解析：我国宫颈癌筛查方案：≥25岁女性首选HPV核酸检测为初筛方法（每5年1次），CIN2+检出灵敏度高，发现异常比细胞学早3～5年。细胞学检查特异度高但灵敏度较低，不作为≥25岁优先推荐的初筛方法。教材P307。

---

191. [A2型题｜应用] batch034-M11-A2-002

> 模块：M11｜页码：教材P311

女，55岁。接触性出血2个月。妇科检查：子宫颈肥大如桶状，质硬，子宫颈口见一3cm×2cm菜花样赘生物，未累及阴道下1/3，子宫旁未触及增厚。超声未见肾盂积水。该患者的临床分期是

- A. ⅠB1期
- B. ⅠB2期 ✅
- C. ⅡA1期
- D. ⅡA2期
- E. ⅡB期

答案：B

> 解析：肿瘤局限于宫颈（未累及阴道下1/3、未达骨盆壁、无肾盂积水），为Ⅰ期。病灶最大径线3cm，＞2cm但≤4cm，符合ⅠB2期（ⅠB1≤2cm，ⅠB2＞2～≤4cm，ⅠB3＞4cm）。教材P311。［源:考研真题 GS-2020-038］

---

192. [A2型题｜应用] batch034-M11-A2-003

> 模块：M11｜页码：教材P327

女，62岁。绝经后阴道流血2个月，分段诊刮病理示子宫内膜样腺癌G1，MRI示肿瘤局限于子宫体，肌层浸润深度＜1/2，无宫颈受累及盆腔淋巴结转移。首选治疗方式是

- A. 高效孕激素口服保守治疗
- B. 全子宫加双侧附件切除术
- C. 筋膜外全子宫双附件+盆腔腹主动脉旁淋巴结 ✅
- D. 根治性盆腔淋巴结放射治疗
- E. 同步放化疗综合治疗方案

答案：C

> 解析：子宫内膜癌早期以手术治疗为首选。本例为ⅠA期G1内膜样癌，标准术式为全面分期手术：筋膜外全子宫+双侧附件切除+盆腔及腹主动脉旁淋巴结切除术（达肾血管水平）。淋巴结切除可判断有无淋巴转移。教材P327。

---

193. [A2型题｜理解] batch034-M11-A2-004

> 模块：M11｜页码：教材P318

女，30岁，妊娠36周。突发下腹痛伴发热，T 38.2℃，恶心呕吐。查体：子宫右前壁局部压痛。超声见子宫右前壁一7cm×6cm低回声区，局部压痛。关于该病例的处理，错误的是

- A. 最可能的诊断是子宫肌瘤红色变性
- B. 妊娠期及产褥期肌瘤易发生红色变性
- C. 首选保守治疗，包括休息、补液、镇痛
- D. 应立即行剖宫产+肌瘤切除术 ✅
- E. 红色变性为肌瘤内小血管退行性变致血供障碍

答案：D

> 解析：妊娠期子宫肌瘤红色变性首选保守治疗（休息、补液、镇痛），通常可缓解。除非保守治疗无效或怀疑其他急腹症，否则不应急于剖宫产+肌瘤切除术。教材P318。

---

194. [A2型题 | 记忆] batch034-M11-A2-005

> 模块：M11 | 页码：教材P304

子宫颈癌最重要的病因是

- A. HIV感染
- B. HBV感染
- C. HPV感染 ✅
- D. HCV感染
- E. EBV感染

答案：C

> 解析：高危型HPV持续感染是子宫颈癌最重要的致病因素，近90%的子宫颈癌和癌前病变组织中可检出高危型HPV。HPV16和18型与约70%的宫颈癌相关。HIV、HBV、HCV、EBV分别与艾滋病、乙型肝炎、丙型肝炎、鼻咽癌等疾病相关。教材P304。［源:考研真题 GS-2007-042］

---

195. [A2型题 | 理解] batch034-M11-A2-006

> 模块：M11 | 页码：教材P324

关于子宫内膜癌相关高危因素的描述，错误的是

- A. 肥胖、糖尿病、高血压合称三联征
- B. 长期无孕激素拮抗的雌激素作用是重要病因
- C. 他莫昔芬长期应用增加风险
- D. 经产妇发病率多于未产妇 ✅
- E. 林奇综合征患者风险增加

答案：D

> 解析：子宫内膜癌的高危因素包括肥胖、糖尿病、高血压（三联征）、不孕、绝经延迟、长期雌激素/他莫昔芬应用、林奇综合征等。未产妇（不孕）的发病风险高于经产妇，因为妊娠期高孕激素水平可保护子宫内膜。教材P324。

---

196. [A3型题｜记忆] batch034-M11-A3-001

> 模块：M11｜页码：教材P307

女，45岁。性生活后阴道流血2周。妇科检查：子宫颈口见一菜花样赘生物，直径约2cm，质脆易出血。HPV核酸检测示HPV16阳性。子宫颈细胞学检查为HSIL。下一步应首选的检查是

- A. 复查HPV检测
- B. 阴道镜指导下子宫颈活组织检查 ✅
- C. 诊断性子宫颈锥切术
- D. 阴道超声及盆腔MRI
- E. 血清肿瘤标志物检查

答案：B

> 解析：宫颈癌诊断遵循三阶梯流程：筛查（HPV/细胞学）→阴道镜→组织病理学。本例HPV16阳性且细胞学HSIL，需转诊阴道镜检查，在阴道镜指导下对可疑病灶行多点活检送病理，以明确诊断及病变程度。活检病理为确诊金标准。教材P307。

---

197. [A4型题｜分析] batch034-M11-A4-001

> 模块：M11｜页码：教材P327

女，58岁。绝经后阴道流血3个月。分段诊刮病理：子宫内膜样腺癌G2。MRI示肿瘤浸润肌层深度＞1/2，子宫颈间质受累，盆腔多发肿大淋巴结。胸腹部CT未见远处转移。该患者FIGO分期及首选治疗策略是

- A. ⅠB期，行筋膜外全子宫+双附件切除术
- B. Ⅱ期行广泛子宫切除双附件+盆腔淋巴结清扫 ✅
- C. ⅢC1期，行同步放化疗
- D. ⅣB期，以全身化疗为主
- E. Ⅱ期，行根治性盆腔淋巴结放疗

答案：B

> 解析：宫颈间质受累为Ⅱ期。肌层浸润＞1/2且盆腔淋巴结转移可疑，需行广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔及腹主动脉旁淋巴结清扫。术后根据病理结果决定辅助治疗（化疗±放疗）。教材P327。

---

198. [B1型题｜应用] batch034-M11-B1-001

> 模块：M11｜页码：教材P320

女，36岁。经量增多2年，Hb 85g/L，超声示子宫黏膜下肌瘤（FIGO 1型）直径3cm。希望保留生育功能。首选手术方式是

- A. 经腹子宫肌瘤切除术
- B. 宫腔镜下子宫肌瘤切除术 ✅
- C. 经腹腔镜子宫肌瘤切除术
- D. 全子宫切除术
- E. 子宫动脉栓塞术

答案：B

> 解析：黏膜下肌瘤（FIGO 1型）突向宫腔，首选宫腔镜下子宫肌瘤切除术，无需开腹，保留子宫及生育功能。肌壁间或浆膜下肌瘤可经腹或腹腔镜切除。教材P320。

---

199. [B1型题｜应用] batch034-M11-B1-002

> 模块：M11｜页码：教材P320

女，48岁。经量增多3年，Hb 78g/L，超声示多发性子宫肌瘤（最大8cm，肌壁间），已完成生育。首选手术方式是

- A. 经腹子宫肌瘤切除术
- B. 宫腔镜下子宫肌瘤切除术
- C. 经腹腔镜子宫肌瘤切除术
- D. 全子宫切除术 ✅
- E. 子宫动脉栓塞术

答案：D

> 解析：多发性子宫肌瘤、症状明显（严重贫血）、无生育要求者，首选全子宫切除术。术前应排除宫颈及子宫内膜恶性病变。子宫肌瘤切除术术后有复发可能。教材P320。

---

200. [X型题｜记忆] batch034-M11-X1-001

> 模块：M11｜页码：教材P317

子宫肌瘤的变性类型包括

- A. 玻璃样变性 ✅
- B. 囊性变 ✅
- C. 红色变性 ✅
- D. 钙化变性 ✅
- E. 脂肪变性

答案：ABCD

> 解析：子宫肌瘤的变性包括玻璃样变性（最常见）、囊性变、红色变性（妊娠期/产褥期特殊类型坏死）、钙化（少见，多见于浆膜下肌瘤及绝经后）、肉瘤变（0.4%～0.8%）。脂肪变性并非子宫肌瘤的典型变性类型。教材P317。

---

201. [X型题｜理解] batch034-M11-X2-001

> 模块：M11｜页码：教材P311

关于子宫颈癌FIGO 2018分期，正确的描述包括

- A. ⅠA1期间质浸润深度≤3mm ✅
- B. ⅠB1期最大径线≤2cm ✅
- C. ⅢC期需标明r（影像学）或p（病理学） ✅
- D. 淋巴脉管间隙浸润（LVSI）不改变分期 ✅
- E. 有疑问时应归入较高分期

答案：ABCD

> 解析：FIGO 2018分期要点：ⅠA1间质浸润≤3mm；ⅠB1最大径线≤2cm；ⅢC期需标注r（影像学）或p（病理学）；LVSI不改变分期；当有疑问时应归入较低分期（而非较高分期）。E选项错误。教材P311。［源:考研真题 GS-2017-151］

M12（20题）

202. [A1型题 | 记忆] batch034-M12-A1-001

> 模块：M12 | 页码：教材P329

卵巢肿瘤中最为常见的组织学类型是

- A. 生殖细胞肿瘤
- B. 上皮性肿瘤 ✅
- C. 性索间质肿瘤
- D. 转移性肿瘤
- E. 未分化肿瘤

答案：B

> 解析：卵巢肿瘤组织学类型分为上皮性肿瘤（占50%-70%）、生殖细胞肿瘤（20%-40%）、性索间质肿瘤（5%-8%）和转移性肿瘤四大类，其中上皮性肿瘤最为常见，占卵巢恶性肿瘤的85%-90%。教材P329。

---

203. [A1型题 | 记忆] batch034-M12-A1-002

> 模块：M12 | 页码：教材P329

卵巢恶性肿瘤最主要的转移途径是

- A. 经血行转移
- B. 直接蔓延扩散
- C. 盆腹腔种植及淋巴转移 ✅
- D. 经神经转移
- E. 经阴道逆行转移

答案：C

> 解析：盆腹腔种植转移和淋巴转移是卵巢恶性肿瘤的主要转移途径，横膈为转移的好发部位，尤其右膈下淋巴丛最易受侵袭。血行转移少见，晚期可转移至肺、肝、脑、骨骼等处。教材P329。

---

204. [A1型题 | 记忆] batch034-M12-A1-003

> 模块：M12 | 页码：教材P330

双侧附件区包块，活检发现癌细胞，首先考虑癌细胞来源于

- A. 子宫
- B. 肠
- C. 胃 ✅
- D. 卵巢
- E. 胰腺

答案：C

> 解析：[源:考研真题 GS-2015-047] 胃癌（尤其胃黏液癌）细胞浸润至浆膜面时脱落种植于盆腔，常在双侧卵巢形成转移性黏液癌，称克鲁根勃（Krukenberg）瘤。

---

205. [A1型题 | 记忆] batch034-M12-A1-004

> 模块：M12 | 页码：教材P345

完全性葡萄胎最常见的染色体核型是

- A. 46,XX ✅
- B. 46,XY
- C. 69,XXY
- D. 69,XXX
- E. 47,XX,+21

答案：A

> 解析：完全性葡萄胎染色体核型为二倍体，均来自父系。90%为46,XX（空卵与单倍体精子23X受精后自身复制），10%为46,XY。部分性葡萄胎90%以上为三倍体如69,XXY。教材P345。

---

206. [A1型题 | 理解] batch034-M12-A1-005

> 模块：M12 | 页码：教材P345

葡萄胎的主要病理变化是

- A. 绒毛水肿，滋养层细胞增生 ✅
- B. 异型滋养细胞浸润深肌层，可见绒毛结构
- C. 异型滋养细胞浸润深肌层，无绒毛、出血坏死
- D. 胎盘种植部位滋养细胞浸润肌层，无出血坏死
- E. 绒毛水肿，滋养层细胞无增生

答案：A

> 解析：[源:考研真题 GS-2010-135] 葡萄胎镜下特点：绒毛水肿增大、绒毛间质内血管消失、滋养层细胞不同程度增生。绒毛膜癌无绒毛结构、出血坏死明显。

---

207. [A1型题 | 理解] batch034-M12-A1-006

> 模块：M12 | 页码：教材P349

绒毛膜癌的组织学特点是

- A. 肿瘤自身无间质血管 ✅
- B. 癌组织出血坏死不明显
- C. 癌细胞形成绒毛结构
- D. 由单一细胞滋养层细胞构成
- E. 可见水肿的绒毛

答案：A

> 解析：绒毛膜癌的特点是无绒毛、无间质、无间质血管。肿瘤自身无间质血管，依靠侵袭宿主血管获取营养，癌组织和周围正常组织有明显出血坏死。镜下由分化不良的细胞滋养层和合体滋养层两种瘤细胞组成。教材P349。 [源:考研真题 GS-2021-039]

---

208. [A1型题 | 理解] batch034-M12-A1-007

> 模块：M12 | 页码：教材P336

卵巢上皮性癌术后首选的一线化疗方案是

- A. BEP方案

- B. 卡铂联合紫杉醇 ✅
- C. 顺铂联合环磷酰胺
- D. 氟尿嘧啶联合奥沙利铂
- E. EMA-CO方案

答案：B

> 解析：卵巢上皮性癌术后辅助化疗多采用以铂类药物为基础的联合化疗，卡铂联合紫杉醇为首选方案。BEP方案用于卵巢恶性生殖细胞肿瘤，EMA-CO方案用于高危妊娠滋养细胞肿瘤。教材P336。

---

209. [A1型题｜应用] batch034-M12-A1-008

> 模块：M12丨页码：教材P346

下列关于绒毛膜癌病理变化的叙述，错误的是

- A. 大片出血
- B. 滋养层细胞增生
- C. 可见胎盘绒毛 ✅
- D. 组织坏死
- E. 无绒毛及间质血管

答案：C

> 解析：[源:考研真题 GS-2008-051] 绒毛膜癌由细胞滋养层和合体滋养层两种癌细胞组成，异型性明显；肿瘤自身无间质血管，出血坏死明显；癌细胞不形成绒毛，故"可见胎盘绒毛"是错误的。

---

210. [A2型题｜应用] batch034-M12-A2-001

> 模块：M12丨页码：教材P330

女，28岁。体位改变后突发左下腹剧痛，伴恶心、呕吐。查体：腹软，左附件区可触及一约8cmx6cm包块，压痛明显，以蒂部为著。最可能的诊断是

- A. 卵巢肿瘤破裂

- B. 卵巢肿瘤蒂扭转 ✅
- C. 卵巢肿瘤感染
- D. 异位妊娠破裂
- E. 急性阑尾炎

答案：B

> 解析：患者体位改变后突发一侧下腹剧痛，附件区压痛包块，以蒂部最明显，符合卵巢肿瘤蒂扭转的典型表现。好发于瘤蒂长、中等大、活动度良好的肿瘤，如成熟性畸胎瘤。一经确诊应尽快手术。教材P330。

---

211. [A2型题｜应用] batch034-M12-A2-002

> 模块：M12丨页码：教材P345

女，26岁。停经12周，阴道不规则流血10日。查体：子宫如孕16周大小，质软。血hCG超过200000IU/L。超声示宫腔内充满蜂窝状回声，未见胎儿结构。最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 部分性葡萄胎
- C. 完全性葡萄胎 ✅
- D. 侵蚀性葡萄胎
- E. 子宫肌瘤合并妊娠

答案：C

> 解析：患者停经后阴道流血、子宫大于停经月份（12周子宫如16周大小）、血hCG异常升高、超声示蜂窝状回声（落雪样征）且无胎儿结构，为完全性葡萄胎的典型表现。完全性葡萄胎无胚胎组织，部分性葡萄胎可有胚胎或孕囊成分。教材P345。

---

212. [A2型题｜理解] batch034-M12-A2-003

> 模块：M12丨页码：教材P348

女，32岁。葡萄胎清宫术后3个月，血hCG持续阳性。行子宫切除术，病理检查见子宫肌层内有水肿的绒毛结构侵入。其诊断是

- A. 葡萄胎病变

- B. 绒毛状腺瘤
- C. 绒毛膜癌病灶
- D. 侵蚀性葡萄胎 ✅
- E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

答案：D

> 解析：镜下见到绒毛可排除绒癌（绒癌无绒毛结构），见绒毛已侵犯子宫肌层说明为浸润性肿瘤，应诊断为侵蚀性葡萄胎。葡萄胎为良性病变无浸润性，绒毛膜癌无绒毛、无间质、无血管。教材P348。［源:考研真题 GS-2017-039］

---

213. [A2型题｜理解] batch034-M12-A2-004

> 模块：M12丨页码：教材P332

关于卵巢良恶性肿瘤的鉴别，下列哪项提示恶性肿瘤

- A. 病程长，逐渐增大
- B. 单侧、囊性、表面光滑、活动
- C. 常有腹腔积液，多为血性 ✅
- D. 一般情况良好状态
- E. 超声示液性暗区，边缘清晰

答案：C

> 解析：卵巢恶性肿瘤的体征多为双侧、固定、实性或囊实性、表面不平结节状，常有腹腔积液（多为血性，可查到癌细胞）。良性肿瘤多为单侧、活动、囊性、表面光滑，常无腹腔积液，一般情况良好。教材P332。

---

214. [A2型题｜应用] batch034-M12-A2-005

> 模块：M12丨页码：教材P350

女，29岁。葡萄胎清宫术后半年，血hCG 5000IU/L，胸部CT示双肺散在转移灶，FIGO预后评分8分（高危）。首选化疗方案是

- A. 单药MTX方案

- B. 单药Act-D方案
- C. EMA-CO方案 ✅
- D. BEP方案
- E. 紫杉醇联合卡铂方案

答案：C

> 解析：妊娠滋养细胞肿瘤根据FIGO预后评分分为低危（<=6分）和高危（>=7分）。低危首选单药化疗（MTX或Act-D），高危首选联合化疗EMA-CO方案。本例评分8分属高危，应选EMA-CO方案。教材P350。

---

215. [A2型题｜应用] batch034-M12-A2-006

> 模块：M12｜页码：教材P335

女，35岁。体检发现左附件区直径5cm囊性包块，超声示囊壁增厚有乳头状突起。手术切除后病理示卵巢交界性浆液性囊腺瘤，无浸润性种植。术后最适宜的处理是

- A. 术后辅助紫杉醇+卡铂化疗6疗程
- B. 术后辅助BEP方案化疗3疗程
- C. 术后辅助放疗方案
- D. 一般不推荐术后辅助化疗，定期随访 ✅
- E. 全子宫双附件切除后观察

答案：D

> 解析：卵巢交界性上皮性肿瘤手术是主要治疗方法，原则行分期手术但不一定行淋巴结切除。一般不推荐术后辅助化疗，仅浸润性种植者可参照低级别上皮性癌辅助化疗方案。本例无浸润性种植，无需化疗，定期随访即可。教材P335。［源:考研真题 GS-2023-040］

---

216. [A3型题｜分析] batch034-M12-A3-001

> 模块：M12｜页码：教材P348

女，33岁。完全性葡萄胎清宫术后随访，第4周血hCG降至正常，第8周重新升高至800IU/L，超声示子宫肌层内见低回声区，血流信号丰富，未见宫腔残留。胸部CT未见异常。最可能的诊断是

- A. 完全性葡萄胎残留
- B. 再次葡萄胎妊娠
- C. 无转移性侵蚀性葡萄胎 ✅
- D. 绒毛膜癌病变
- E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

答案：C

> 解析：葡萄胎清宫后hCG转阴后再升高，影像学提示子宫肌层浸润，应考虑妊娠滋养细胞肿瘤（GTN）。本例为葡萄胎后继发，葡萄胎后1年内发生者多为侵蚀性葡萄胎，且无远处转移，属无转移性GTN。葡萄胎后超过1年发生则绒癌可能性大。教材P348。

---

217. [A4型题｜应用] batch034-M12-A4-001

> 模块：M12｜页码：教材P330

女，24岁，未婚。突发左下腹剧痛4小时，伴恶心呕吐。查体：T 37.8度，左附件区可触及一7cmx6cm囊性包块，压痛，蒂部明显。超声示左附件区囊性包块，内见脂液分层征，提示成熟性畸胎瘤，卵巢血流信号减弱。术中见左卵巢肿瘤扭转2周，呈暗紫色，尚未坏死。既往有类似发作史1次。最适宜的手术方式是

- A. 先行扭转复位，再行卵巢肿瘤剥除术 ✅
- B. 直接行左附件切除术
- C. 全子宫双附件切除术
- D. 行左卵巢肿瘤剥除术后再复位
- E. 仅行扭转复位，保留卵巢观察

答案：A

> 解析：卵巢肿瘤蒂扭转一经确诊应尽快手术。对于年轻患者，若扭转时间短、卵巢尚未坏死，可行扭转复位后行卵巢肿瘤剥除术，尽量保留正常卵巢组织。若已发生坏死则行患侧附件切除术。本例患者年轻未婚，卵巢呈暗紫色但尚未坏死，应先行复位再剥除肿瘤。教材P330。

---

218. [B1型题｜理解] batch034-M12-B1-001

> 模块：M12｜页码：教材P331

对卵巢卵黄囊瘤具有特异性诊断价值的肿瘤标志物是

- A. CA125
- B. AFP ✅
- C. hCG
- D. 抑制素
- E. CA199

答案：B

> 解析：血清AFP对卵巢卵黄囊瘤（内胚窦瘤）具有特异性诊断价值。CA125与HE4联合用于上皮性卵巢癌监测，hCG用于非妊娠性绒癌，抑制素用于颗粒细胞瘤。教材P331。

---

219. [B1型题｜理解] batch034-M12-B1-002

> 模块：M12｜页码：教材P331

对卵巢颗粒细胞瘤具有诊断价值的标志物是

- A. CA125
- B. AFP检测
- C. 血hCG测定
- D. 抑制素和雌激素 ✅
- E. CA199

答案：D

> 解析：卵巢颗粒细胞瘤可分泌雌激素和抑制素，抑制素（inhibin）是颗粒细胞瘤的特异性标志物。卵泡膜细胞瘤也可分泌雌激素。支持-间质细胞瘤可分泌雄激素。教材P331。

---

220. [X型题｜记忆] batch034-M12-X1-001

> 模块：M12｜页码：教材P329

绒毛膜癌区别于恶性葡萄胎的病理特点有

- A. 呈浸润性生长

- B. 出血、坏死更明显 ✅
- C. 滋养细胞增生
- D. 无绒毛和水泡形成 ✅

答案：BD

> 解析：[源:考研真题 GS-2019-149] 绒癌与恶性葡萄胎均可滋养细胞大量增生、呈浸润性生长；恶性葡萄胎可见水泡状绒毛，绒癌出血坏死更明显且无绒毛结构，此为两者鉴别要点。

---

221. [X型题 | 理解] batch034-M12-X2-001

> 模块：M12 | 页码：教材P345

关于完全性葡萄胎的描述，正确的有

- A. 染色体核型为二倍体，来自父系 ✅
- B. 缺乏胚胎或胎儿组织 ✅
- C. 绒毛水肿、血管消失、滋养细胞弥漫增生 ✅
- D. P57免疫组化染色阴性 ✅
- E. 染色体核型为三倍体

答案：ABCD

> 解析：完全性葡萄胎染色体核型为二倍体，全部来自父系（90%为46,XX），缺乏胚胎或胎儿组织，绒毛显著水肿、血管消失、滋养细胞弥漫增生。因无母源染色体，P57免疫组化染色阴性。三倍体是部分性葡萄胎的特征。教材P345。 [源:考研真题 GS-2024-151]

M13（9题）

222. [A1型题 | 记忆] batch034-M13-A1-001

> 模块：M13 | 页码：教材P368

异常子宫出血（AUB）的PALM-COEIN分类中，属于器质性病因的组别是

- A. PALM分类组 ✅
- B. COEIN分类组

- C. PALM与COEIN均器质性
- D. 两者均为非器质性
- E. 仅C和O为器质性

答案：A

> 解析：PALM-COEIN分类将AUB病因分为九亚型：PALM（器质性，包括子宫内膜息肉、子宫腺肌病、子宫平滑肌瘤、子宫内膜恶变及不典型增生）和COEIN（非器质性，包括全身凝血相关疾病、排卵障碍、子宫内膜局部异常、医源性、未分类）。教材P368。

---

223. [A1型题 | 记忆] batch034-M13-A1-002

> 模块：M13 | 页码：教材P369

排卵后形成的黄体可分泌的激素是

- A. 黄体生成素
- B. 卵泡刺激素
- C. 促性腺激素释放激素
- D. 人绒毛膜生长素
- E. 孕激素和雌激素 ✅

答案：E

> 解析：[源:考研真题 GS-2004-016（原X型改编为A1）] 黄体由排卵后残留的颗粒细胞和卵泡膜细胞在LH作用下形成，分泌孕激素及雌激素。LH、FSH由腺垂体分泌，GnRH由下丘脑分泌，人绒毛膜生长素由胎盘分泌。

---

224. [A1型题 | 记忆] batch034-M13-A1-004

> 模块：M13 | 页码：教材P386

妊娠时维持黄体功能的主要激素是

- A. 雌激素（E2）
- B. 孕激素（孕酮）
- C. 促卵泡激素

- D. 黄体生成素
- E. 绒毛膜促性腺激素 ✅

答案：E

> 解析：[源:考研真题 GS-1996-016] 妊娠时维持黄体功能的主要激素是绒毛膜促性腺激素（hCG，由合体滋养细胞分泌），并非黄体生成素。排卵后黄体分泌雌激素和孕激素。

---

225. [A1型题 | 应用] batch034-M13-A1-008

> 模块：M13 | 页码：教材P394

关于绝经激素治疗（MHT）的适应证，错误的是

- A. 血管舒缩症状（潮热、盗汗）
- B. 泌尿生殖道萎缩症状（GSM）
- C. 低骨量及骨质疏松骨折风险
- D. 乳腺癌术后患者 ✅
- E. 早发性卵巢功能不全的HRT

答案：D

> 解析：MHT适应证包括：绝经相关症状（血管舒缩症状、精神神经症状）、泌尿生殖道萎缩症状（GSM）、低骨量及骨质疏松骨折风险、过早低雌激素状态（POI、下丘脑-垂体闭经、手术绝经）。乳腺癌是MHT的禁忌证，与性激素相关恶性肿瘤均禁用MHT。教材P394。

---

226. [A2型题 | 理解] batch034-M13-A2-001

> 模块：M13 | 页码：教材P371

女，16岁。初潮2年，月经周期不规则，经量多。本次月经持续15日未净，量多伴头晕。Hb 85g/L。生命体征稳定。止血应首选

- A. 诊断性刮宫术
- B. 孕激素内膜脱落法 ✅
- C. 大剂量雌激素内膜修复法
- D. GnRH-a治疗

- E. 行子宫切除术

答案：B

> 解析：青春期AUB-O患者止血首选孕激素内膜脱落法（即药物刮宫），适用于Hb大于90g/L、生命体征稳定者。本例Hb 85g/L略低于90g/L，但生命体征稳定仍可考虑药物刮宫；也可选用复方短效口服避孕药。诊断性刮宫青春期患者原则上不首选。教材P371。

---

227. [A2型题｜应用] batch034-M13-A2-004

> 模块：M13｜页码：教材P394

女，52岁。绝经1年，潮热、盗汗、失眠症状明显，要求MHT治疗。既往体健，无血栓病史，乳腺超声正常。有完整子宫。MHT方案应选择

- A. 单用口服雌激素
- B. 雌孕激素连续联合方案 ✅
- C. 单用孕激素治疗
- D. 单用雄激素治疗
- E. 无需加孕激素，单用雌激素即可

答案：B

> 解析：有子宫的女性使用MHT时，必须在雌激素基础上加用孕激素，以保护子宫内膜、预防子宫内膜癌。连续联合方案适用于绝经后女性，每日同时服用雌孕激素，可避免周期性出血。单用雌激素会增加子宫内膜癌风险，为禁忌。教材P394。

---

228. [A3型题｜分析] batch034-M13-A3-001

> 模块：M13｜页码：教材P375

女，48岁。月经量增多、经期延长1年，近3个月阴道不规则流血。Hb 75g/L。超声示子宫内膜厚1.6cm，回声不均，宫腔内可见一1.5cmx1.0cm高回声团。宫腔镜活检病理示子宫内膜复杂性增生伴不典型增生。最恰当的治疗是

- A. 孕激素后半周期治疗
- B. 宫腔镜下子宫病灶切除术
- C. 行全子宫切除术 ✅

- D. GnRH-a治疗3个月后观察
- E. 放置LNG-IUS

答案：C

> 解析：子宫内膜不典型增生（AUB-M）属于癌前病变，进展为子宫内膜癌的风险高。对于围绝经期女性，无生育要求者应行全子宫切除术。孕激素治疗适用于年轻、有生育要求者。LNG-IUS可用于子宫内膜增生但非首选。教材P375。

---

229. [X型题｜理解] batch034-M13-X1-001

> 模块：M13丨页码：教材P386

女性，19岁。海外留学回国休假，因月经不调就诊。患者诉出国后月经不正常，担心因不适应当地气候身体出现问题。此时最佳的沟通是

- A. 仅关注月经异常并诊治
- B. 关注月经，了解国外心理状况并诊治
- C. 关注月经，了解国外社会适应性并诊治
- D. 关注月经，兼顾心理社会适应性，诊治并安慰 ✅
- E. 忽略月经问题，仅行心理咨询

答案：D

> 解析：[源:考研真题 GS-2021-110] 医患沟通应坚持整体原则。月经不调不仅涉及生理因素，也可能涉及心理和社会因素，应全面关注月经情况并了解心理与社会适应性，予以诊治和安慰。

---

230. [X型题｜记忆] batch034-M13-X2-001

> 模块：M13丨页码：教材P394

绝经激素治疗（MHT）的禁忌证包括

- A. 已知或可疑妊娠 ✅
- B. 原因不明的阴道流血 ✅
- C. 乳腺癌病史记录 ✅

- D. 近6个月活动性静脉血栓栓塞 ✅
- E. 无症状子宫肌瘤

答案：ABCD

> 解析：MHT禁忌证包括：已知或可疑妊娠、原因不明阴道流血、乳腺癌或与性激素相关的其他恶性肿瘤、近6个月内活动性静脉/动脉血栓栓塞、严重肝肾功能不全。无症状子宫肌瘤属于慎用情况而非绝对禁忌。教材P394。

M14（20题）

231. [A1型题｜记忆] batch034-M14-A1-001

> 模块：M14丨页码：教材P396

女性不孕症的诊断标准是：夫妇有正常性生活、未避孕，未孕时间至少达

- A. 6个月
- B. 12个月 ✅
- C. 18个月
- D. 24个月
- E. 36个月

答案：B

> 解析：女性未避孕正常性生活至少12个月未孕称为不孕症，男性则称为不育症；既往从未妊娠为原发性不孕，既往有过妊娠后不孕为继发性不孕。我国不孕症发病率为7%～10%。教材P396。

---

232. [A1型题｜理解] batch034-M14-A1-002

> 模块：M14丨页码：教材P396

下列不属于女性不孕症盆腔因素的是

- A. 输卵管梗阻
- B. 子宫内膜异位症

- C. 子宫腔粘连
- D. 多囊卵巢综合征 ✅
- E. 子宫颈黏液异常

答案：D

> 解析：盆腔因素是我国女性不孕症（尤其继发性不孕）最主要的原因，约占35%，包括输卵管病变、子宫体病变、子宫颈因素、子宫内膜异位症及生殖器官发育异常。多囊卵巢综合征属于排卵障碍性病因（排卵障碍占女性不孕的25%～35%），不属于盆腔因素。教材P396。

---

233. [A1型题｜记忆] batch034-M14-A1-003

> 模块：M14｜页码：教材P410

各种输卵管绝育术中失败率（再通率）最低的是

- A. 硅胶绝育环
- B. 弹簧夹绝育
- C. 双极电凝法 ✅
- D. 输卵管折叠结扎切除法
- E. 输卵管银夹法

答案：C

> 解析：腹腔镜输卵管绝育术各种术式中，电凝术失败率最低（再通率0.19%），硅胶环0.33%，弹簧夹高达2.71%；但机械性绝育术毁损组织少，为日后输卵管复通提供更高成功率。教材P410。

---

234. [A1型题｜应用] batch034-M14-A1-004

> 模块：M14｜页码：教材P404

育龄女性要求放置宫内节育器，下列不属于放置禁忌证的是

- A. 妊娠或可疑妊娠
- B. 生殖器官肿瘤
- C. 生殖道急性炎症

- D. 铜过敏病史
- E. 子宫腔深度8.0cm ✅

答案：E

> 解析：IUD放置禁忌证包括妊娠或可疑妊娠、生殖道急性炎症、生殖器官肿瘤、生殖器畸形、子宫脱垂、宫腔深度＜5.5cm或＞9.0cm、近3个月月经失调、铜过敏史（不宜含铜IUD）等。子宫腔深度8.0cm在5.5～9.0cm允许范围内，不属于禁忌证。教材P404。

---

235. [A1型题｜记忆] batch034-M14-A1-005

> 模块：M14｜页码：教材P397

不孕（育）症夫妇首选的检查项目是

- A. 腹腔镜检查
- B. 宫腔镜检查
- C. 性激素六项测定
- D. 超声监测排卵
- E. 精液分析 ✅

答案：E

> 解析：精液分析是不孕（育）症夫妇首选的检查项目，按《世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册》（第6版）进行，需行2～3次检查明确精液质量。女方检查还包括排卵功能与输卵管通畅性评估。教材P397。

---

236. [A1型题｜理解] batch034-M14-A1-006

> 模块：M14｜页码：教材P397

评价输卵管通畅度的首选方法是

- A. 腹腔镜检查输卵管
- B. 宫腔镜检查
- C. 子宫输卵管X线造影 ✅
- D. 基础体温测定

- E. 诊断性刮宫

答案：C

> 解析：子宫输卵管X线造影是评价输卵管通畅度的首选方法，应在月经干净后3～7日进行，既可评估子宫腔病变，又可了解输卵管通畅度；三维实时超声子宫输卵管造影也是可靠方法。宫腔镜、腹腔镜适用于提示宫腔或盆腔异常者的进一步诊治。教材P397。

---

237. [A1型题 | 理解] batch034-M14-A1-007

> 模块：M14 | 页码：教材P398

氯米芬诱发排卵的作用机制是

- A. 补充外源性FSH促进卵泡发育
- B. 竞争性结合雌激素受体，解除雌激素负反馈 ✅
- C. 抑制芳香化酶减少雌激素合成
- D. 模拟LH峰以诱发排卵
- E. 抑制垂体催乳素分泌作用

答案：B

> 解析：氯米芬竞争性结合下丘脑和垂体雌激素受体，抑制雌激素的负反馈作用，使促性腺激素分泌增加，促进卵泡生长。补充外源性FSH为hMG/hFSH的作用；抑制芳香化酶为来曲唑；模拟LH峰为绒促性素；抑制PRL为溴隐亭。教材P398。

---

238. [A1型题 | 理解] batch034-M14-A1-008

> 模块：M14 | 页码：教材P400

卵巢过度刺激综合征（OHSS）的主要病理生理改变，错误的是

- A. 全身血管通透性增加
- B. 体液进入腹腔、胸腔
- C. 血液浓缩状态
- D. 免疫复合物沉积致器官损害 ✅
- E. 重要脏器血栓形成风险增加

答案：D

> 解析：OHSS为促排卵药物刺激卵巢后多个卵泡发育、雌激素水平过高，引起全身血管通透性增加、体液外渗入体腔、血液浓缩及血流动力学改变，hCG升高会加重病理进程，严重者可致血栓形成、电解质紊乱甚至死亡。其发病与免疫复合物沉积无关。教材P400。

---

239. [A2型题 | 应用] batch034-M14-A2-001

> 模块：M14 | 页码：教材P397

女，29岁。婚后正常性生活未避孕2年未孕，月经规律，男方精液分析2次均正常。女方下一步应首选的检查是

- A. 子宫输卵管X线造影 ✅
- B. 腹腔镜检查
- C. 宫腔镜检查
- D. 染色体核型分析
- E. 诊断性刮宫

答案：A

> 解析：不孕症诊断应夫妇双方同时进行：男方精液分析已正常、女方月经规律提示排卵可能正常，下一步首选评估输卵管通畅度，即月经干净后3～7日行子宫输卵管X线造影。腹腔镜/宫腔镜仅用于提示盆腔或宫腔异常者。教材P397。

---

240. [A2型题 | 应用] batch034-M14-A2-002

> 模块：M14 | 页码：教材P398

女，26岁。多囊卵巢综合征，婚后未避孕1年未孕，男方精液正常、女方输卵管通畅。拟诱导排卵，首选药物是

- A. 溴隐亭
- B. 氯米芬 ✅
- C. 绒促性素
- D. 孕激素
- E. 甲状腺素片

答案：B

> 解析：氯米芬适用于下丘脑-垂体-卵巢轴反馈机制健全、体内有一定雌激素水平的排卵障碍者，为PCOS诱导排卵的常用首选，月经第3～5日起每日50mg连用5日，排卵率70%～80%。溴隐亭用于高催乳素血症，绒促性素用于卵泡成熟后诱发排卵。教材P398。

---

241. [A2型题 | 记忆] batch034-M14-A2-003

> 模块：M14 | 页码：教材P399

女，30岁。闭经6个月，双乳挤出乳汁，血清PRL 120μg/L，垂体MRI未见占位。所致排卵障碍的首选治疗药物是

- A. 氯米芬
- B. hMG
- C. 溴隐亭 ✅
- D. 醋酸甲羟孕酮
- E. 甲状腺素

答案：C

> 解析：高催乳素血症导致的排卵障碍首选溴隐亭（多巴胺受体激动剂，抑制垂体分泌PRL），自1.25mg/d开始酌情增至2.5mg/d，每3～6个月复查血清PRL。教材P399。

---

242. [A2型题 | 记忆] batch034-M14-A2-004

> 模块：M14 | 页码：教材P412

女，28岁。停经48日要求终止妊娠，血hCG阳性，超声确诊宫内妊娠。药物流产的正确用药方案是

- A. 米索前列醇单用
- B. 米非司酮单用
- C. 缩宫素联合米索前列醇
- D. 米非司酮序贯米索前列醇 ✅
- E. 依沙吖啶羊膜腔注射

答案：D

> 解析：药物流产采用米非司酮（抗孕激素制剂）配伍米索前列醇（前列腺素类似物），完全流产率达90%以上；顿服法200mg或分服法总量150mg，于服药第3日晨口服米索前列醇0.6mg。早孕≤49日可在门诊行药物流产。教材P412。

---

243. [A2型题 | 理解] batch034-M14-A2-005

> 模块：M14 | 页码：教材P409

女，35岁。行腹腔镜下输卵管绝育术，术后咨询生殖内分泌改变。正确的是

- A. 无排卵，有月经
- B. 无排卵，无月经
- C. 有排卵，有月经 ✅
- D. 有排卵，无月经
- E. 无排卵，经量增多

答案：C

> 解析：输卵管绝育仅阻断精子与卵子相遇，不影响“下丘脑-垂体-卵巢-子宫轴”调控，卵巢仍正常排卵，子宫内膜仍周期性脱落形成月经。教材P409。［源:考研真题 GS-2024-016］

---

244. [A2型题 | 理解] batch034-M14-A2-006

> 模块：M14 | 页码：教材P408

女，24岁。无保护性生活后52小时，要求紧急避孕，平素月经规律，无激素应用禁忌。可采用的补救措施是

- A. 复方短效口服避孕药按周期服用
- B. 含铜宫内节育器（5日内）或口服左炔诺孕酮 ✅
- C. 皮下埋植剂立即放置避孕
- D. 米非司酮10mg每日口服连用14日
- E. 无需处理，仅观察月经

答案：B

> 解析：紧急避孕为无保护性生活后或避孕失败后的补救措施：含铜IUD在无保护性生活后5日（120小时）内放入，失败率低于1%；左炔诺孕酮片在72小时内服1片、12小时后重复1片；米非司酮10mg于72小时内顿服。紧急避孕不能替代常规避孕，仅对本次无保护性生活有效。教材P408。

---

245. [A3型题｜分析] batch034-M14-A3-001

> 模块：M14｜页码：教材P412

女，26岁。停经58日行负压吸引术，手术顺利，术后阴道流血13日未净，量时多时少，无发热及腹痛。血hCG较术后3日下降缓慢，超声示宫腔内1.8cm×1.2cm不均质高回声，肌层血流正常。最可能的诊断是

- A. 吸宫不全 ✅
- B. 漏吸妊娠物
- C. 子宫穿孔
- D. 人工流产综合征
- E. 宫颈粘连

答案：A

> 解析：吸宫不全指人工流产术后部分妊娠组织物残留，是人工流产术常见并发症，与操作者技术不熟练或子宫位置异常有关；表现为术后阴道流血时间长、血量多或流血停止后再现多量流血，血或尿hCG下降缓慢，超声示宫腔不均质回声有助于诊断。漏吸为未吸出胚胎及绒毛而继续妊娠，多见于早孕期或子宫畸形、位置异常；本例术后流血13日伴宫腔残留征象，符合吸宫不全。无明显感染征象可行清宫术，清出物送病理。教材P412。

---

246. [A4型题｜应用] batch034-M14-A4-001

> 模块：M14｜页码：教材P412

女，32岁。哺乳期，停经50日行负压吸引术，探针进入深度明显超过此前所测子宫腔深度，患者仅轻微腹痛，无内出血表现，吸宫操作尚未开始。正确的处理是

- A. 继续手术，完成吸宫操作
- B. 立即行剖腹探查
- C. 立即行子宫动脉栓塞

- D. 立即停止手术并密切观察 ✅
- E. 1周后直接行钳刮术

答案：D

> 解析：手术器械进入深度超过原测深度提示子宫穿孔（哺乳期妊娠子宫为高危因素），应立即停止手术。穿孔小、无脏器损伤或内出血者可注射子宫收缩剂保守治疗并预防感染，密切观察血压、脉搏；宫内组织未吸净者由有经验医师避开穿孔部位，在超声或腹腔镜引导下完成手术，尚未吸宫且无出血者可等待1周后再清宫；破口大、有内出血或疑脏器损伤才需剖腹探查。教材P412。

---

247. [B1型题｜应用] batch034-M14-B1-001

> 模块：M14｜页码：教材P413

新婚夫妇尚未生育，应首选的避孕方法是

- A. 复方短效口服避孕药 ✅
- B. 避孕套避孕
- C. 宫内节育器
- D. 安全期避孕
- E. 输卵管绝育术

答案：A

> 解析：新婚期原则为选择使用方便、不影响生育的方法：复方短效口服避孕药使用方便、避孕效果好、不影响性生活，为首选；男用避孕套也是较理想方法；尚未生育者宫内节育器不作为首选，不宜用安全期、体外排精及长效避孕药。教材P413。

---

248. [B1型题｜理解] batch034-M14-B1-002

> 模块：M14｜页码：教材P413

产后3个月哺乳期女性，宜选择的最佳避孕方法是

- A. 复方短效口服避孕药
- B. 避孕套避孕 ✅
- C. 宫内节育器立即放置

- D. 安全期避孕
- E. 输卵管绝育术

答案：B

> 解析：哺乳期避孕原则为不影响乳汁质量及婴儿健康：避孕套是哺乳期最佳避孕方式；产后6周后可选用单孕激素避孕方法；哺乳期不宜使用雌、孕激素复合避孕药或避孕针及安全期避孕；哺乳期放置IUD需操作轻柔防子宫损伤，并非“最佳”。教材P413。

---

249. [X型题｜记忆] batch034-M14-X1-001

> 模块：M14｜页码：教材P407

甾体激素避孕药的禁忌证包括

- A. 严重心血管疾病及血栓性疾病 ✅
- B. 急、慢性肝炎或肾炎 ✅
- C. 年龄＞35岁的吸烟女性 ✅
- D. 乳腺癌术后患者 ✅
- E. 单纯性外阴阴道假丝酵母菌病

答案：ABCD

> 解析：甾体激素避孕药禁忌证包括：严重心血管疾病、血栓性疾病（高血压、冠心病、静脉栓塞等）；急、慢性肝炎或肾炎；性激素依赖性肿瘤或癌前病变（如乳腺癌）；年龄＞35岁的吸烟女性；哺乳期不宜含雌激素制剂；严重偏头痛反复发作等。单纯外阴阴道假丝酵母菌病不属于禁忌证。教材P407。

---

250. [X型题｜理解] batch034-M14-X2-001

> 模块：M14｜页码：教材P411

负压吸引术的并发症包括

- A. 人工流产综合征 ✅
- B. 子宫穿孔损伤 ✅
- C. 吸宫不全残留 ✅

- D. 羊水栓塞发生 ✅
- E. 卵巢过度刺激综合征

答案：ABCD

> 解析：人工流产术并发症包括人工流产综合征、出血、子宫穿孔、漏吸或空吸、吸宫不全、感染及羊水栓塞（少见，症状轻于晚期妊娠）；远期可致宫颈及宫腔粘连、慢性盆腔炎、继发性不孕等。卵巢过度刺激综合征是辅助生殖促排卵的并发症，与人工流产无关。教材P411。

📌 图谱归属：题库与真题 MOC ｜ 知识图谱总览